ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

REUMATOLOGÍA

90 preguntas de práctica

Inmunología Clínica

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Reumatología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR					
1.04.2.007	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q3, Q4, Q9, Q10, Q11, Q12	Tomo 02 · 1.1 (Pág. 5)
1.05.1.001	Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q14, Q15, Q16	Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30)
1.11.1.002	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q5	Tomo 17 · 17.4 (Pág. 17)
1.11.1.003	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q6	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.004	Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q18	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.007	Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q17	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.015	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q7	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.016	Oligoartritis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.019	Poliartritis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.2.001	Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q13	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.2.002	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
BLOQUE 2: ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO					
1.05.1.001	Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q19, Q28, Q29, Q30, Q31, Q33, Q34, Q35, Q36	Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30)
1.05.1.002	Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q20, Q21, Q22, Q23	Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11)
1.10.1.001	Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q24, Q25, Q26, Q27	Tomo 09 · 9.7 (Pág. 26)
1.11.1.014	Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q32	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
BLOQUE 3: ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES					

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.01.1.006	Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q37, Q38, Q39, Q40	Tomo 01 · 5.9 (Pág. 105)
1.05.1.004	Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q44, Q45, Q46, Q47	Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66)
1.05.1.012	Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q53	Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41)
1.11.1.009	Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q41	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.020	Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q48, Q49, Q50, Q51, Q52	Tomo 09 · 9.13 (Pág. 51)
1.11.1.021	Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q42	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.022	Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q54	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.023	Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q43	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
BLOQUE 4: ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET					
1.04.1.010	Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q69, Q70	Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35)
1.05.1.001	Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q55, Q56	Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30)
1.05.1.015	Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q71, Q72	Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62)
1.08.1.002	Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q60, Q61, Q62, Q63	Tomo 08 · 8.2 (Pág. 7)
1.11.1.001	Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q65, Q66, Q67, Q68	Tomo 09 · 9.18 (Pág. 68)
1.11.1.006	Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q64	Tomo 13 · 13.13 (Pág. 52)
1.11.1.012	Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q57	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.013	Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q58	Tomo 09 · C.35 (Pág. 74)
1.11.1.018	Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q59	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
BLOQUE 5: VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO					

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.09.1.008	Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q77, Q78, Q79, Q80	Tomo 09 · 9.21 (Pág. 77)
1.09.1.009	Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q82, Q83, Q84, Q85	Tomo 05 · 5.3 (Pág. 69)
1.09.1.012	Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q86, Q87	Tomo 09 · 9.23 (Pág. 85)
1.09.1.014	Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q89	Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63)
1.11.1.005	Cervicalgia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.008	Epicondilalgia, epitroclealgias	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.010	Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.011	Hombro doloroso	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q75	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.017	Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q90	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.024	Tendonitis y bursitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q76	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.025	Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q81	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Reumatología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.01.1.006	Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q37, Q38, Q39, Q40	Tomo 01 · 5.9 (Pág. 105)
1.04.1.010	Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q69, Q70	Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35)
1.04.2.007	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q3, Q4, Q9, Q10, Q11, Q12	Tomo 02 · 1.1 (Pág. 5)
1.05.1.001	Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q14, Q15, Q16, Q19, Q28, Q29, Q30, Q31, Q33, Q34, Q35, Q36, Q55, Q56	Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30)
1.05.1.002	Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q20, Q21, Q22, Q23	Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11)
1.05.1.004	Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q44, Q45, Q46, Q47	Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66)
1.05.1.012	Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q53	Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41)
1.05.1.015	Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q71, Q72	Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62)
1.08.1.002	Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q60, Q61, Q62, Q63	Tomo 08 · 8.2 (Pág. 7)
1.09.1.008	Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q77, Q78, Q79, Q80	Tomo 09 · 9.21 (Pág. 77)
1.09.1.009	Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q82, Q83, Q84, Q85	Tomo 05 · 5.3 (Pág. 69)
1.09.1.012	Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q86, Q87	Tomo 09 · 9.23 (Pág. 85)
1.09.1.014	Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q89	Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63)
1.10.1.001	Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q24, Q25, Q26, Q27	Tomo 09 · 9.7 (Pág. 26)
1.11.1.001	Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q65, Q66, Q67, Q68	Tomo 09 · 9.18 (Pág. 68)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.11.1.002	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q5	Tomo 17 · 17.4 (Pág. 17)
1.11.1.003	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q6	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.004	Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q18	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.005	Cervicalgia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.006	Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q64	Tomo 13 · 13.13 (Pág. 52)
1.11.1.007	Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q17	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.008	Epicondilalgia, epitroclealgias	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.009	Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q41	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.010	Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.011	Hombro doloroso	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q75	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.012	Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q57	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.013	Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q58	Tomo 09 · C.35 (Pág. 74)
1.11.1.014	Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q32	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.015	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q7	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.016	Oligoartritis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.017	Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q90	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.018	Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q59	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.019	Poliartritis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.020	Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis,	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q48, Q49, Q50, Q51, Q52	Tomo 09 · 9.13 (Pág. 51)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto				
1.11.1.021	Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q42	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.022	Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q54	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.023	Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q43	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.024	Tendonitis y bursitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q76	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.025	Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q81	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.2.001	Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q13	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.2.002	Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR

PREGUNTA 1 1.11.1.016

1. [ATENCIÓN PRIMARIA: Oligoartritis · 1.11.1.016] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Oligoartritis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 2 1.11.1.019

2. [ATENCIÓN PRIMARIA: Poliartritis · 1.11.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Poliartritis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 1.04.2.007

3. Un paciente de 70 años consulta por dolor muy intenso en la rodilla izquierda, asociada a aumento de volumen, calor local y eritema. Al examen físico presenta derrame articular y signos inflamatorios en dicha articulación. Se realiza una radiografía de rodilla, que muestra una línea de calcificación a nivel del cartílago articular. La artrocentesis da salida a un líquido turbio, de filancia disminuida, con cerca de 10.000 células, con 90% de polimorfonucleares. La microscopía en el microscopio de campo oscuro observa múltiples cristales con birrefringencia de elongación positiva. La 3/endocrinologiadiabetologiay-nutriciondiabetologiaynutriciontraumatologia/ 1/7 tinción de Gram no muestra bacterias. La conducta más adecuada es:

A) Enviar a domicilio con paracetamol oral y una dieta pobre en calcio

B) Iniciar AINEs y alopurinol oral

C) Solicitar niveles plasmáticos de ácido úrico, calcemia y paratohormona y decidir manejo según resultados

D) Iniciar AINEs endovenosos y reposo

E) Iniciar antibióticos endovenosos y realizar drenaje articular

PREGUNTA 4 1.04.2.007

4. Un hombre de 69 años, sin antecedentes médicos de interés, presenta una monoartritis aguda de rodilla. La radiografía simple de rodilla muestra calcificación de ambos meniscos. Se realiza una artrocentesis, obteniéndose un líquido articular inflamatorio, con visualización de cristales abundantes con birrefringencia de elongación positiva, sin visualización de bacterias. En sus exámenes generales presenta hemograma normal, ácido úrico: 8,0 mg/dl, calcemia: 10 mg/dl, creatinina: 0,8 mg/dl. La conducta más adecuada para el tratamiento agudo es:

A) AINEs y reposo

B) AINEs, bifosfonatos y reposo

C) AINEs, antibióticos, bifosfonatos y reposo

D) AINEs, diuréticos y reposo

E) AINEs, alopurinol y reposo

PREGUNTA 5 1.11.1.002

5. Un paciente de 20 años, con antecedente de gastroenteritis aguda hace dos semana, consulta por dolor en tobillo derecho desde hace 1 día. Refiere haber presentado molestias similares hace una semana en rodilla y pie izquierdo. Al examen físico destaca tobillo derecho con eritema leve, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Artritis por cristales

B) Artritis por stafilococo aureus

C) Artritis por neisseria gonorrhoeae

D) Artritis reactiva

E) Artritis reumatoídea juvenil

PREGUNTA 6 1.11.1.003

6. Paciente con dolor articular en MCF e IFP, con rigidez matinal importante. ¿Cuál es el examen específico a solicitar?

A) Factor reumatoide (IgM)
B) ANA y anti-DNA doble cadena
C) Ácido úrico sérico
D) Anticuerpos anti-CCP
E) HLA-B27

PREGUNTA 7 1.11.1.015

7. Un paciente de 78 años consulta por gonalgia derecha intensa, que impide la marcha, asociada a aumento de volumen. Al examen físico presenta edema, eritema y aumento de la temperatura local, con signos de derrame articular. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar antibióticos endovenosos
B) Solicitar factor reumatoide, ANA y ácido úrico
C) Iniciar AINEs
D) Realizar artrocentesis diagnóstica
E) Solicitar resonancia magnética nuclear de rodilla

PREGUNTA 8 1.11.2.002

8. Un paciente de 45 años ha presentado 3 episodios de gota en el último año, por lo que se inició tratamiento colchicina y luego se agregó alopurinol 100 mg/día. Actualmente está asintomático, sin signos de artritis y se controlar uricemia de 7 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender el tratamiento
B) Aumetar la dosis de alopurinol a 300 mg/día
C) Agregar probenecid al tratamiento
D) Suspender la colchicina
E) Agregar prednisona en baja dosis

PREGUNTA 9 1.04.2.007

9. En un adolescente con síntomas de artritis séptica del tobillo derecho se realiza estudio de líquido sinovial que muestra un aspecto turbio, poco filante, con células 85.000 x mm3, con 95% de polimorfonucleares y visualización de abundantes cocáceas Gram negativas intracelulares. La conducta más adecuada es:

A) Administrar penicilina benzatina
B) Iniciar flucloxacilina oral
C) Iniciar cloxacilina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
D) Iniciar vancomicina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
E) Iniciar ceftriaxona endovenosa y realizar drenaje quirúrgico

PREGUNTA 10 1.04.2.007

10. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en la artritis séptica de rodilla, con presencia de cocaceas Gram (-) intracelulares y cultivo negativo del líquido articular?

A) Anaerobios
B) Chlamydia trachomatis
C) Neisseria gonorrhoeae
D) Streptococcus agalactiae
E) Staphylococcus aureus

PREGUNTA 11 1.04.2.007

11. Un paciente de 33 años es diagnosticado de artritis séptica de cadera izquierda por estudio de líquido sinovial, con visualización de cocáceas Gram positivas dispuestas en racimo. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar cloxacilina oral e indicar uso de muletas, prohibiendo el apoyo de la extremidad
B) Iniciar ceftriaxona endovenosa e indicar uso de muletas, prohibiendo el apoyo de la extremidad
C) Iniciar vancomicina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación
D) Iniciar clindamicina oral y realizar aseo quirúrgico de la articulación
E) Iniciar cefazolina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación

PREGUNTA 12 1.04.2.007

12. Un paciente de 56 años consulta por intenso dolor en rodilla derecha. Al examen se aprecia rodilla derecha eritematosa, caliente y aumentada de volumen. Se realiza artrocentesis, con salida de líquido turbio, poco filante. El estudio citológico demuestra más de 100.000 células, con 90% de polimorfonucleares. La microscopía demuestra cristales escasos de pirofosfato de calcio y la tinción de Gram demuestra cocáceas gran positivas en racimo. El tratamiento de elección es:

A) Drenaje quirúrgico, asociado a Vancomicina endovenosa
B) Drenaje quirúrgico, asociado a Cloxacilina endovenosa
C) Cefazolina endovenosa, en dosis altas
D) Drenaje quirúrgico y tratamiento antibiótico intraarticular
E) Cefadroxilo por vía oral

PREGUNTA 13 1.11.2.001

13. Una paciente de 61 años, hipertensa y diabética, en tratamiento regular con hipoglicemiantes orales y antihipertensivos, desde hace 3 días presenta dolor y aumento de volumen en hombro derecho. Al examen físico presenta temperatura 38,2 °C, eritema, rubor y aumento de volumen del hombro derecho y limitación funcional, que impide el movimiento. El diagnóstico más probable es:

A) Gota
B) Condrocalcinosis
C) Artritis reumatoidea
D) Artritis séptica
E) Artritis reactiva

PREGUNTA 14 1.05.1.001

14. **Un hombre de 69 años, sin antecedentes médicos de interés, presenta una monoartritis aguda de rodilla. La radiografía simple de rodilla muestra calcificación de ambos meniscos. Se realiza una artrocentesis, obteniéndose un líquido articular inflamatorio, con visualización de cristales abundantes con birrefringencia de elongación positiva, sin visualización de bacterias. En sus exámenes generales presenta hemograma normal, ácido úrico: 8,0 mg/dl, calcemia: 10 mg/dl, creatinina: 0,8 mg/dl. La conducta más adecuada para el tratamiento agudo y para prevenir nuevas crisis es respectivamente:**

A) Agudo: AINEs y reposo; Prevenir nuevas crisis: Bifosfonatos
B) Agudo: AINEs y reposo; Prevenir nuevas crisis: No deben indicarse medicamentos
C) Agudo: AINEs y bifosfonatos; Prevenir nuevas crisis: Bifosfonatos
D) Agudo: AINEs y reposo; Prevenir nuevas crisis: Alopurinol
E) Agudo: AINEs y bifosfonatos; Prevenir nuevas crisis: Alopurinol

PREGUNTA 15 1.05.1.001

15. **Un paciente de 70 años presenta una artritis aguda de rodilla, la que se punciona, dando salida a un líquido inflamatorio, con 10.000 células por mm3, con abundantes cristales, compatibles con pirofosfato de calcio, sin visualización de bacterias. La conducta más adecuada es:**

A) Indicar reposo e iniciar AINES
B) Indicar reposo, iniciar analgésicos y alopurinol
C) Indicar reposo, iniciar analgésicos y bifosfonatos
D) Indicar reposo, iniciar analgésicos, bifosfonatos y alopurinol
E) Indicar reposo, iniciar analgésicos, antibióticos y bifosfonatos

PREGUNTA 16 1.05.1.001

16. **Un paciente de 68 años consulta por dolor intenso de la rodilla izquierda, de 4 horas de evolución, asociado a aumento de volumen. Al examen físico se aprecia enrojecimiento, aumento de la temperatura local y derrame articular, con intenso dolor a la movilización activa y pasiva de la articulación. Se solicita radiografía de rodilla, que muestra una línea de calcificación del cartílago articular y se realiza estudio del líquido sinovial, demostrándose la presencia de abundantes cristales con birrefringencia de elongación positiva. La tinción de Gram no visualiza bacterias. La conducta más adecuada es:**

A) Realizar drenaje articular y administrar analgésicos y bifosfonatos
B) Indicar reposo e iniciar analgésicos y bifosfonatos
C) Indicar reposo e iniciar analgésicos y sulfato de magnesio
D) Indicar reposo e iniciar analgésicos y antibióticos empíricos
E) Indicar reposo e iniciar analgésicos

PREGUNTA 17 1.11.1.007

17. **Paciente con varios episodios de artritis de rodilla; punción muestra cristales de pirofosfato de calcio intracelulares. ¿Tratamiento para prevenir nuevas crisis?**

A) AINES a demanda
B) Alopurinol
C) Metotrexato oral semanal
D) Infiltración con corticoides
E) Colchicina profiláctica

PREGUNTA 18 1.11.1.004

18. **Una paciente de 61 años consulta por dolor articular de ambas manos. Al examen se aprecia aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Se solicita radiografía de manos, que muestra disminución simétrica del espacio interarticular de las articulaciones interfalángicas, con compromiso de la primera articulación carpometacarpiana bilateral, con presencia de quistes subcondrales. Los ANA y FR resultan positivos. El diagnóstico más probable es:**

A) Artritris psoriática
B) Artriris reumatoide
C) Artritis reactiva
D) Condrocalcinosis
E) Artrosis

BLOQUE 2 ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

PREGUNTA 19 1.05.1.001

19. **El lupus inducido por drogas suele presentar:**

A) Anticuerpos anti-DNA de doble hebra
B) Anticuerpos anti-proteína P
C) Anticuerpos anti-Ro
D) Anticuerpos anti-histona
E) Anticuerpos anti-ribonucleoproteína

PREGUNTA 20 1.05.1.002

20. **Un hombre de 40 años presenta rigidez matinal de una hora y artralgias de articulaciones metacarpofalángicas, muñecas y tobillos, desde hace 6 semanas. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y signos inflamatorios en las articulaciones descritas. El diagnóstico más probable es:**

A) Artritis reumatoide
B) Artritis por cristales
C) Artrosis
D) Lupus eritematoso
E) Artritis viral

PREGUNTA 21 1.05.1.002

21. **Una paciente de 36 años consulta por artralgias de manos de algunos meses de evolución, asociados a rigidez matinal de 1 hora aproximadamente. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y signos inflamatorios en la mayoría de las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas de ambas manos. El diagnóstico más probable es:**

A) Artrosis 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesy-nutricion6
B) Artritis reumatoide
C) Artritis psoriática
D) Lupus sistémico
E) Esclerodermia

PREGUNTA 22 1.05.1.002

22. **¿Cuál de las siguientes NO suele ser una manifestación extra articular de la artritis reumatoide?**

A) Fibrosis pulmonar
B) Mielitis transversa
C) Vasculitis de vaso pequeño 18gastroenterologia7
D) Pericarditis
E) Síndrome de Sjörgren secundario

PREGUNTA 23 1.05.1.002

23. **¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele aparecer en los pacientes con artritis reumatoide?**

A) Mano en ráfaga
B) Dedos en cuello de cisne
C) Dedos en sastre
D) Nódulos de Heberden
E) Nódulos reumatoídeos

PREGUNTA 24 1.10.1.001

24. **Un paciente de 43 años es diagnosticada de artritis reumatoide. El tratamiento de primera línea es:**

A) Indometacina
B) Metotrexato
C) Prednisona
D) Ciclofosfamida
E) Paracetamol

PREGUNTA 25 1.10.1.001

25. **¿Cuál de las siguientes alteraciones es menos probable de encontrar en un paciente con artritis reumatoide?**

A) Nódulos reumatoídeos
B) Derrame pleural
C) Nefritis
D) Anemia
E) Miocarditis

PREGUNTA 26 1.10.1.001

26. **El tratamiento de elección de la artritis reumatoide es:**

A) Paracetamol
B) AINES
C) Prednisona
D) Metotrexato
E) Prednisona + ciclofosfamida

PREGUNTA 27 1.10.1.001

27. **Una paciente de 40 años presenta dolor en las manos desde hace 3 meses. Refiere marcada rigidez articular, que dura cerca de una hora. Al examen físico se aprecia artritis de ambas muñecas y de varias articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, de manera bilateral. El tratamiento de elección de la patología descrita es:**

A) Paracetamol
B) Prednisona
C) Ciclofosfamida + corticoides
D) Alopurinol más AINEs
E) Metotrexato

PREGUNTA 28 1.05.1.001

28. **¿Qué anticuerpo es más sensible para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico?**

A) Anti-DNA de una hebra
B) Anti-DNA de dos hebras
C) Anti-Sm
D) Anti-nucleares
E) Anti-citoplasma de neutrófilo

PREGUNTA 29 1.05.1.001

29. **Una paciente de 30 años consulta por eritema de la cara, sobre el dorso de la nariz y los pómulos, que respeta el surco nasolabial y que suele aparecer luego de la exposición solar. El diagnóstico más probable es:**

A) Dermatomiositis
B) Esclerodermia
C) Lupus eritematoso sistémico
D) Lupus discoide
E) Arteritis de Wegener

PREGUNTA 30 1.05.1.001

30. **En una paciente de 25 años de edad, sin antecedentes mórbidos, que consulta por un cuadro de tres semanas de evolución, caracterizado por compromiso del estado general, fiebre continua, erupción cutánea nasogeniana, alopecía, fenómeno de Raynaud, poliartralgias y derrame pleural, su primera hipótesis diagnóstica es:**

A) Esclerosis Sistémica Progresiva
B) Lupus Eritematoso Sistémico
C) Artritis Reumatoidea
D) Vasculitis
E) Síndrome de Sobreposición

PREGUNTA 31 1.05.1.001

31. **Una mujer de 35 años presenta astenia, adinamia, fiebre intermitente, artralgias y caída del cabello, de 3 semanas de evolución. Al examen se aprecia en buenas condiciones, con signos vitales normales. En en paladar blando se observan 2 úlceras de cerca de 5 mm cada una. Se solicitan exámenes generales, con los siguientes resultados: Hematocrito: 34%; VCM: 30 fl; glóbulos blancos: 4.600 x mm3; neutrófilos: 78%; monocitos: 9%; linfocitos: 13%; plaquetas: 70.000 x mm3; VHS: 44 mm/h; creatinina plasmástica: 2,2 mg/dl; BUN: 28 mg/dl;s hepáticas normales. El diagnóstico más probable es:**

A) Infección por CMV
B) Infección por VIH
C) Leucemia aguda
D) Linfoma
E) Lupus sistémico

PREGUNTA 32 1.11.1.014

32. **Una mujer de 30 años presenta un cuadro de malestar general y artralgias de varias semanas de evolución, asociada a febrícula ocasional. Al examen físico se aprecia rash facial, úlceras orales, alopecia difusa, artritis de varias articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas de ambas manos. Se solicitan exámenes, entre los que se encuentran hemograma con hematocrito: 30%, hemoglobina: 10 g/dl, leucocitos: 4.000 por mm3, con 15% de linfocitos, además se solicitan ANA (+) en dilución 1:640, Anti-DNA de 2 hebras (+) en dilución 1:160, C3: 60 mg/dl, C4:11 mg/dl, factor reumatoide: 65 U/ml y Anti-CCP (-). El diagnóstico más probable es:**

A) Artritis reumatoide
B) Púrpura trombocitopénico trombótico
C) Lupus eritematoso sistémico
D) Vasculitis
E) Dermatomiositis

PREGUNTA 33 1.05.1.001

33. **Una paciente de 20 años consulta por fiebre, astenia, artralgias y hematuria. Al examen físico se aprecia artritis de manos, sin otras alteraciones. En sus exámenes generales destaca elevación de la creatinina hasta 2,1 mg/dl y hematuria dismórfica. El diagnóstico más probable es:**

A) Esclerodermia
B) Crioglobulinemia
C) Poliangeítis microscópica
D) Lupus
E) Artritis reumatoide

PREGUNTA 34 1.05.1.001

34. **Un hombre de 68 años, diabético tipo 2, en tratamiento con dieta desde hace 10 años, presenta astenia y edema de extremidades inferiores. El examen físico no presenta otras alteraciones. Se solicitan exámenes que constatan un clearence de creatinina de 30 ml/min, BUN: 50 mg/dl, proteinuria de 24 horas de 1,2 gramos, sedimento de orina con 0-2 glóbulos rojos por campo, sin leucocituria, albuminemia de 4,2 g/dl, HbA1c: 8% y perfil lipídico con 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesy-nutricion/ 4/9 hipercolesterolemia. El diagnóstico más probable es:**

A) Nefropatía diabética
B) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
C) Glomeruloesclerosis difusa
D) Glomerulopatía membranosa
E) Nefritis intersticial

PREGUNTA 35 1.05.1.001

35. **Un niño de 6 años presenta un cuadro caracterizado por orinas espumosas y aumento de volumen facial, especialmente en los párpados. Al examen físico se aprecia edema facial y de extremidades, presión arterial normal, sin otras alteraciones. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 0,6 mg/dl, proteinuria de 100 mg/m2/hora, albuminemia: 2,8 g/dl, elevación del colesterol, sedimento de orina normal, ANA negativos, ANCA negativos y complemento normal. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar furosemida
B) Iniciar prednisona
C) Iniciar enalapril
D) Realizar biopsia renal
E) Observar evolución

PREGUNTA 36 1.05.1.001

36. **Un paciente de 67 años consulta por artralgias y fiebre de 3 días de evolución, asociados a hematuria y oliguria importante. En sus exámenes generales se aprecia hematuria dismórfica, elevación de la creatinina hasta 3,5 mg/dl, anticuerpos antinucleares negativos y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos en patrón perinuclear. El diagnóstico más probable es:**

A) Poliangeítis microscópica
B) Panarteritis nodosa
C) Vasculitis granulomatosa de Wegener
D) Vasculitis alérgica de Churg-Strauss
E) Arteritis de la temporal Respuestas: Prueba 13 Diabetes y Nutrición + Reumatología Preguntas Respuestas 1 C 2 E 3 C 4 A 5 E 6 A 7 C 8 B 9 D 10 E 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesy-nutricion6 11 E P1re2paración EUNACOM C 13 B 14 B 15 B 16 D 17 E 18 B 19 C 20 A Todos los Derechos Reservados para DrGuevara - 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesynutricion6

BLOQUE 3 ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES

PREGUNTA 37 1.01.1.006

37. **El síndrome antifosfolípidos se asocia a todo lo siguiente EXCEPTO:**

A) Acortamiento del TTPA
B) Trombosis arteriales
C) Trombosis venosasoncologia/ 2/621/12/2016 Prueba 3 | Dr. Guevara
D) Abortos Dr. Guevara
E) Lupus eritematosos sistémico Preparación EUNACOM

PREGUNTA 38 1.01.1.006

38. Paciente de 34 años con antecedentes de tres abortos previos y trombosis venosa profunda en el último año, sin otros síntomas. Se realiza estudio por sus antecedentes donde destacan ANA (+), anticuerpos antifosfolípidos (+), anticuerpos anticardiolipinas (+) y factor reumatoide (+) ¿Cuál es el manejo más adecuado para la paciente?:

A) Iniciar tratamiento con prednisona oral
B) Iniciar tratamiento anticoagulante
C) Iniciar tratamiento con metotrexato
D) Iniciar tratamiento con azatioprina
E) Iniciar tratamiento con aspirina

PREGUNTA 39 1.01.1.006

39. Enferma de 36 años con antecedentes de esplenectomía por trombocitopenia a los 22 años y cuatro abortos, el último seguido de un cuadro de trombosis venosa profunda. Desde hace unas 8 semanas presenta un cuadro de artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre. ¿Cuál de las siguientess de laboratorio cree de mayor utilidad para llegar al diagnóstico?:

A) Factor reumatoide y anticuerpos antinucleares (ANA).
B) Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticardiolipina.
C) Factor reumatoide y anticuerpo enfermedad de Lyme.
D) Anticuerpo anti-ADN nativo y anti-Ro (SSA).
E) Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCAs) y antihistonas.

PREGUNTA 40 1.01.1.006

40. ¿Cuál de las siguientes pacientes puede utilizar anticonceptivos orales sin mayor contraindicación?

A) Mujer con cáncer de mama
B) Mujer diagnosticada de melanoma
C) Mujer con daño hepático crónico por NASH
D) Mujer con déficit de antitrombina III
E) Mujer con antecedente de abortos a repetición

PREGUNTA 41 1.11.1.009

41. Una paciente de 47 años, con antecedente de pirosis y dolor epigástrico de 8 meses de evolución, consulta por disfagia ilógica, de localización alta, que ha ido en aumento. Refiere fenómeno de Raynaud y al examen físico se aprecia esclerodactilia, telangiectasias en el pecho y piel de la cara indurada, sin líneas de expresión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Acalasia esofágica
B) Esclerosis sistémica
C) Dermatomiositis
D) Lupus eritematoso sistémico
E) Enfermedad mixta del tejido conectivo

PREGUNTA 42 1.11.1.021

42. Mujer joven, aborto hace 3 meses, tiene anemia, hace una TVP confirmada por eco doppler, estudio etiológico:

A) SAF
B) Estudio Lupus
C) Pedir antitrombina III
D) Estudio TVP??
E) Hemograma y VHS

PREGUNTA 43 1.11.1.023

43. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome de túnel carpiano · 1.11.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome de túnel carpiano. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 44 1.05.1.004

44. Los pacientes con esclerodermia sistémica limitada (CREST) suelen desarrollar:

A) Fibrosis pulmonar
B) Accidentes vasculares encefálicos
C) Cáncer
D) Hipertensión pulmonar
E) Uveítis

PREGUNTA 45 1.05.1.004

45. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre marcadores inmunológicos y patología es correcta?

A) Anticuerpos anti-ribonucleoproteína – Dermatomiositis
B) Anticuerpos anti-proteína P – Actividad lúpica
C) Anticuerpos anti-histona – Enfermedad de Sjörgren
D) Anticuerpos anticentrómero – Esclerodermia
E) Anticuerpos antinucleares, patrón citoplasmático – Poliangeítis microscópica

PREGUNTA 46 1.05.1.004

46. Una paciente de 55 años comienza con disnea progresiva y edema en las extremidades inferiores. Diez años antes había sido diagnosticada de esclerosis sistémica (ES) debido a la presencia de fenómeno de Raynaud, esclerodermia localizada y la detección de anticuerpos anticentrómero en sangre. Estaba controlada con 7,5 mg de prednisona diarios y cremas vasodilatadoras aplicadas en manos. En su evaluación en el momento de la disnea, la gasometría arterial demostraba hipoxia y en la radiografía de tórax no se veía ninguna afectación parenquimatosa. ¿Cuál es la causa más probable del cuadro actual de esta paciente?:

A) Insuficiencia respiratoria restrictiva muscular.
B) Endocarditis de Libmann Sachs de la tricúspide.
C) Insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a la miocardiopatía de la E.S. 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesynutricion6
D) Hipertensión pulmonar.
E) Tromboembolismo pulmonar de repetición.

PREGUNTA 47 1.05.1.004

47. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es más frecuente en los pacientes con esclerodermia sistémica limitada?

A) Artritis de pequeñas articulaciones
B) Fenómeno de Raynaud
C) Eritema cutáneo
D) Fibrosis pulmonar
E) Insuficiencia renal

PREGUNTA 48 1.11.1.020

48. Un hombre de 68 años, diabético mal controlado, consulta por mialgias generalizadas de 2 semanas de evolución, mayores en los muslos, asociadas a debilidad, mayor en la cintura pélvica y astenia. En el último tiempo refiere dificultades para ponerse de pie, desde una silla o desde la cama. Al examen físico se objetiva debilidad muscular de predominio proximal, sin alteraciones sensitivas. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con hemoglobina: 12,1 g/dl, hematocrito: 37%, blancos: 7.000 por mm3, plaquetas: 250.000 por mm3, VHS: 10 mm/hora. Además, trae glicemia: 150 mg/dl, creatinfosfoquinasa: 1.760 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 mg/L, SGOT: 250 UI/L, SGPT: 170 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polimiositis
B) Polimialgia reumática
C) Polineuropatía diabética
D) Miopatía por cuerpos de inclusión
E) Síndrome de Guillain Barré

PREGUNTA 49 1.11.1.020

49. ¿Qué lesión cutánea es característica de la dermatomiositis?

A) Eritema nodoso
B) Eritema malar
C) Eritema en manto
D) Granuloma anular
E) Pioderma gangrenoso

PREGUNTA 50 1.11.1.020

50. ¿Qué marcador suele alterarse con mayor frecuencia en la dermatomiositis?

A) Complemento
B) Factor reumatoídeo
C) Velocidad de sedimentación hemática
D) Anticuerpos antinucleares
E) Creatinfosfoquinasa

PREGUNTA 51 1.11.1.020

51. La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune, que ha sido asociada a la presencia de un cáncer concomitante. Los marcadores inmunológicos más característicos de esta patología son:

A) Anticuerpos anti centrómero
B) Anticuerpos anti nucléolo
C) Anticuerpos anti Jo-1
D) Anticuerpos anti Ro y anti La
E) Anticuerpos anti ribonucleoproteína

PREGUNTA 52 1.11.1.020

52. Acude a su consulta una paciente de 31 años por cuadro de 1 semana de evolución con debilidad en las masas musculares proximales, apareciendo eritema violáceo en párpados superiores y eritema en hombros y región superior del tórax. Usted sospecha una dermatomiositis. ¿Qué marcadores serológicos espera que resulten alterados para confirmar el diagnóstico?

A) Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA) y VHS
B) Anticuerpos antinucleares (ANA) y C3 disminuido
C) Factor reumatoídeo
D) Creatinkinasa (CK) y anticuerpos anti Jo-1
E) Anticuerpos anti-RNP

PREGUNTA 53 1.05.1.012

53. El fenómeno de Raynaud es característico de la siguiente patología:

A) Esclerodermia
B) Dermatomiositis
C) Síndrome de Sjörgren
D) Artritis reumatoide
E) Artritis psoriática

PREGUNTA 54 1.11.1.022

54. Una paciente de 43 años presenta sequedad bucal, asociada a ardor y sensación de arenilla ocular y a artralgias. Al examen físico tiene sequedad de piel y de mucosas, se observa aumento de volumen de ambas parótidas y se palpan adenopatías submandibulares de consistencia aumentada. Se solicitan exámenes, que muestra FR: 40 UI/nl, ANA positivos 1/16, ENA negativo, antiDNA negativo. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio diagnóstico?

A) Punción parotidea
B) Biopsia ganglionar
C) Anticuerpos anti-CCP
D) Biopsia de glándula salival accesoria
E) Anticuerpos anti-Sm

BLOQUE 4 ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET

PREGUNTA 55 1.05.1.001

55. Todas las siguientes son manifestaciones de la espondilitis anquilosante (anquilopoyética) EXCEPTO:

A) Dolor lumbar y rigidez de más de 3 meses que mejora con el ejercicio pero no con el reposo.
B) Sacroileitis radiológica bilateral.
C) Uveítis aguda anterior.
D) Insuficiencia aórtica.
E) Vasculitis de pequeños vasos

PREGUNTA 56 1.05.1.001

56. **Hombre de 24 años, deportista. Consulta por dolor glúteo y lumbar de semanas de evolución, que lo despierta en la noche y que se alivia con la actividad. Refiere además talalgia matinal bilateral y una molestia en el tendón aquiliano izquierdo. Ha ingerido antiinflamatorios con disminución parcial y transitoria de los síntomas. Desde ayer nota que el segundo ortejo del pie derecho está rojo y doloroso. El diagnóstico más probable es:**

A) Artritis séptica
B) Pelviespondilopatía
C) Gota
D) Condrocalcinosis
E) Lumbago mecánico

PREGUNTA 57 1.11.1.012

57. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Lumbago infeccioso y tumoral · 1.11.1.012] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Lumbago infeccioso y tumoral. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 58 1.11.1.013

58. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Lumbago mecánico · 1.11.1.013] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Lumbago mecánico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 59 1.11.1.018

59. **Un paciente de 39 años, trabajador de la construcción, con IMC de 30, psoriático, consulta por dolor en la zona glútea profunda, de predominio nocturno, muy intenso y que va desapareciendo en la mañana, a medida que realiza sus actividades. El dolor inició hace 3 meses y ha aumentado. Hace 2 meses presentó una uveítis derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Radiculopatía S1
B) Espondiloartritis
C) Espondilodiscitis
D) Hernia del núcleo pulposo con compresión del plexo lumbar
E) Raquiestenosis

PREGUNTA 60 1.08.1.002

60. **Un paciente de 27 años presenta un cuadro de dolor lumbar crónico, mayor en reposo, asociado a rigidez matinal. En alguna ocasión presentó artritis de la rodilla derecha. Se solicita radiografía de articulaciones sacroilíacas que demuestra signos de sacroileítis bilateral y de algún grado de calcificación de los ligamentos longitudinales anterior y posterior. El tratamiento de elección de la patología descrita es:**

A) Corticoesteroides y kinesioterapia
B) Metotrexato y ciclosporina
C) Antiinflamatorios no esteroidales y ejercicios 3/endocrinologia-diabetologiaynutriciondiabetologiaynutriciontraumatologia/ 2/7
D) Metotrexato y ejercicios
E) Ciclosfosfamida y corticoides

PREGUNTA 61 1.08.1.002

61. **Un hombre de 23 años presenta dolor lumbar insidioso, mayor al despertar, pero que va disminuyendo, a medida que hace ejercicio. Además presenta sensación febril ocasional. Al examen físico tiene clara limitación a la flexión de la columna lumbar y la radiografía lumbosacra muestra sacroileítis bilateral y calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar AINEs e indicar ejercicios periódicos
B) Iniciar costicoides e indicar ejercicios periódicos
C) Iniciar metotrexato e indicar ejercicios periódicos
D) Iniciar hidroxicloroquina e indicar ejercicios periódicos
E) Iniciar ciclosporina e indicar ejercicios periódicos

PREGUNTA 62 1.08.1.002

62. **Un hombre de 25 años consulta por lumbago crónico, de predominio nocturno, que cede con el reposo, asociado a rigidez lumbar. Se solicita radiografía de articulaciones sacroilicas, que muestra signos de sacroileítis y calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar metotrexato
B) Iniciar ciclosporina
C) Iniciar corticoides orales e indicar ejercicios
D) Iniciar AINES e indicar ejercicios
E) Resolver quirúrgicamente

PREGUNTA 63 1.08.1.002

63. **Un paciente de 25 años consulta por dolor lumbar de 4 meses de evolución, que es mayor en la mañana y se asocia a rigidez matinal, cediendo a medida que realiza actividad física. Al examen físico presenta marcada dificultad para flectar la columna, llegando a tocar sólo las rodillas con las extremidades inferiores extendidas. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar aines y reposo relativo, indicando control en caso de recurrencia
B) Iniciar analgésicos, relajantes musculares y kinesioterapia
C) Solicitar radiografía de columna lumbosacra
D) Solicitar RMN de columna lumbosacra
E) Iniciar corticoides orales y ejercicios

PREGUNTA 64 1.11.1.006

64. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Columna dolorosa · 1.11.1.006] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Columna dolorosa. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 65 1.11.1.001

65. **Una paciente de 42 años presenta artritis de las articulaciones interfalángicas distales y proximales de ambas manos, con afectaciónreciente de una articulación metatarsofalángica. Al examen físico, además de las artritis descritas, presenta múltiples depresiones en las uñas de las manos y engrosamiento de las uñas de los pies. ¿A qué tipo de artritis corresponde este cuadro?**

A) Reumatoide
B) Reactiva
C) Psoriática
D) Gotosa
E) Lúpica

PREGUNTA 66 1.11.1.001

66. **La artritis psoriática se manifiesta con mayor frecuencia como:**

A) Una monoartritis aguda migratoria y recidivante
B) Una oligoartritis que compromete las articulaciones cuya piel circundante presenta placas psoriáticas
C) Una oligoartritis asimétrica y migratoria de grandes y pequeñas articulaciones, asociada a dactilitis
D) Una poliartritis simétrica distal, de pequeñas y grandes articulaciones, asociadas a rigidez matinal de más de 30 minutos de duración
E) Una poliartritis de pequeñas articulaciones, asimétrica, asociada a compromiso renal

PREGUNTA 67 1.11.1.001

67. **Una mujer de 32 años presenta lesiones en las uñas, consistentes en depresiones puntiformes, similares a picotazos. El diagnóstico más probable es:**

A) Onicomicosis
B) Onicogrifosis
C) Liquen plano
D) Psoriasis
E) Onicocriptosis

PREGUNTA 68 1.11.1.001

68. **Una paciente de 40 años presenta artri8s de muñecas y de ar8culaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales de ambas manos, de 6 semanas de evolución. Recientemente se agregó dolor y aumento de volumen generalizado del segundo ortejo derecho, que le dificulta la marcha. Al examen Fsico se aprecia aumento de volumen y eritema de las ar8culaciones descritas, más lesiones deprimidas pun8formes en las uñas de las manos, con engrosamiento de las uñas de los pies. El cuadro descrito corresponde a una artri8s de 8po:**

A) Reumatoide
B) Infecciosa
C) Reac2va
D) Psoriá2ca
E) Gotosa

PREGUNTA 69 1.04.1.010

69. **Un paciente de 45 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia cuadro de dolor lumbar, artritis de rodillas y manos, asociados a ojo rojo profundo y disuria. El diagnóstico más probable es:**

A) Púrpura trombocitopénico trombótico
B) Síndrome de Reiter
C) Enfermedad de Behcet
D) Vasculitis de Wegener
E) Crioglobulinemia

PREGUNTA 70 1.04.1.010

70. **Un paciente de 45 años inicia un cuadro de dolor lumbar insidioso, mayor con el reposo, asociado a artritis de rodillas y manos, con a ojo rojo y disuria dolorosa. Refiere estar utilizando doxiciclina, hace una semana, debido a una enfermedad de transmisión sexual. El diagnóstico más probable es:**

A) Lupus por drogas
B) Síndrome de Reiter
C) Vasculitis leucocitoclástica
D) Reacción fototóxica secundaria al uso de tetraciclinas
E) Espondilitis anquilosante

PREGUNTA 71 1.05.1.015

71. **Hombre de 29 años consulta por aftas bucales dolorosas muy recurrentes en labios y encías desde hace 2 años y antecedentes de úlceras dolorosas en escroto que dejaron cicatriz. En la exploración oftalmológica se detecta uveítis anterior con nivel de hipopión en cámara anterior. Al realizar unade punción cutánea con aguja estéril en el antebrazo se aprecia a las 36 horas una pápula eritematosa con una pústula estéril central de 3 mm. ¿Cómo se denomina estacutánea diagnóstica?**

A) Prueba de Mitsuda
B) Fenómeno de Patergia
C) Signo de Darier
D) Prueba de Kveim-Siltzbach
E) Signo de Nikolsky

PREGUNTA 72 1.05.1.015

72. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las úlceras orales y genitales en la Enfermedad de Behçet es CORRECTA?**

A) Las úlceras orales son indoloras y las genitales no duelen
B) Las úlceras genitales curan típicamente dejando cicatriz atrófica permanente, mientras que las orales curan sin cicatriz
C) Las úlceras genitales se acompañan de adenopatías inguinales supurativas
D) Las úlceras orales están presentes en menos del 20% de los pacientes diagnosticados
E) El tratamiento de elección de las úlceras orales es aciclovir oral

BLOQUE 5 VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO

PREGUNTA 73 1.11.1.005

73. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Cervicalgia · 1.11.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cervicalgia. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 1.11.1.008

74. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Epicondilalgia, epitroclealgias · 1.11.1.008] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Epicondilalgia, epitroclealgias. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 75 1.11.1.011

75. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hombro doloroso · 1.11.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hombro doloroso. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 76 1.11.1.024

76. [ATENCIÓN PRIMARIA: Tendonitis y bursitis · 1.11.1.024] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tendonitis y bursitis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 77 1.09.1.008

77. Hombre de 72 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, se asocia a astenia y claudicación mandibular intermitente. Refiere cansancio al peinarse y al realizar otras actividades en las que tenga que mantener los brazos levantados por algunos minutos. El diagnóstico más probable es:

A) Polimiositis
B) Fibromialgia
C) Arteritis de la temporal
D) Poliangeítis microscópica
E) Panarteritis nodosa

PREGUNTA 78 1.09.1.008

78. Una paciente de 67 años presenta astenia y debilidad de las extremidades superiores, de predominio proximal, asociada a claudicación mandibular, cefalea frecuente y fiebre ocasional. En sus exámenes generales destaca anemia con marcada elevación de la VHS. El diagnóstico más probable es: 3/endocrinologia-diabetologiaynutriciondiabetesynutricion6

A) Granulomatosis de Wegener
B) Lupus sistémico
C) Poliangeítis microscópica
D) Arteritis de células gigantes
E) Polimiositis

PREGUNTA 79 1.09.1.008

79. Un paciente de 65 años presenta astenia y debilidad muscular, especialmente al levantar los brazos y en la musculatura proximal de las extremidades inferiores. También refiere que presenta cefalea frecuente y dolor al masticar por mucho tiempo, lo que lo obliga a comer lento. En sus exámenes destaca anemia normocícita normocrómica, con VHS: 97 mm/h. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar metotrexato
B) Iniciar naproxeno
C) Solicitar angiografía
D) Solicitar ecografía doppler carotídeo
E) Iniciar prednisona 1mg/Kg y solicitar biopsia de arteria temporal

PREGUNTA 80 1.09.1.008

80. La arteritis de Takayasu se manifiesta con todo lo siguiente, EXCEPTO:

A) Glomerulonefritis
B) Artralgias6
C) Fiebre
D) Accidente vascular encefálico
E) Asimetría de los pulsos radiales

PREGUNTA 81 1.11.1.025

81. Un paciente de 75 añosconsulta por cefalea de 2 semanas de evolución, holocránea, intensa, que ha ido en aumento. En el último tiempo refiere además dolor al tocarse el cuero cabelludo y dolor en la rodilla derecha. Al examen físico se constatan signos de derrame articular de la rodilla derecha. Se realiza exámenes, entre los que figura un hemograma, con hemoglobina: 12,0 g/dl, blancos: 9.600 por mm3 y VHS: 76 mm/h. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis seronegativa
B) Arteritis de células gigantes
C) Artritis reactiva
D) Lupus
E) Endocarditis aguda

PREGUNTA 82 1.09.1.009

82. Las vasculitis alérgica de Churg-Strauss, presenta ANCA positivo, en una proporción moderada de los casos. Clínicamente se manifiesta como:

A) Asma de difícil manejo, que luego se acompaña de glomerulonefritis
B) Exantema purpúrico, de extremidades inferiores, con hematuria, artritis y compromiso gastrointestinas, como hematoquezia por ejemplo
C) Rinosinusitis de difícil manejo, seguida de hemoptisis y glomerulonefritis, con rápido deterioro de la función renal
D) Cefalea, fiebre, amaurosis fugax, claudicación mandibular, polimialgia reumática y elevación de la VHS
E) Exantema pseudopapular (ronchas) muy pruriginoso, con lesiones que confluyen hasta formar grandes placas, afectando las mucosas y asociándose a hipotensión arterial

PREGUNTA 83 1.09.1.009

83. Un paciente de 32 años presenta una rinosinusitis crónica de difícil manejo, asociado a epistaxis frecuente. En el último tiempo se agrega compromiso del estado general, fiebre, hematuria y oliguria. En sus exámenes destaca ANCA 4/921/12/2016 Prueba 11 | Dr. Guevara positivos en patrón "c". El diagnóstico de sospecha es: Dr. Guevara

A) Púrpura de Schöenlein-Henoch Preparación EUNACOM
B) Granulomatosis de Wegener
C) Vasculitis de Churg-Strauss
D) Lupus sistémico eritematoso
E) Panarteritis nodosa

PREGUNTA 84 1.09.1.009

84. La presentación clínica más habitual de la granulomatosis de Wegener es:

A) Astenia, fiebre, compromiso de coronarias y arterias mesentéricas
B) Glomuronefritis rápidamente progresiva y ANCA positivo en patrón perinuclear
C) Asma refractario a tratamiento y con posterioridad afectación renal
D) Rinosinusitis de difícil manejo, asociada a glomerulonefritis rápidamente progresiva y afectación pulmonar
E) Insuficiencia renal, hematuria, accidentes vasculares encefálicos a repetición y púrpura palpable de extremidades inferiores

PREGUNTA 85 1.09.1.009

85. Un paciente de 65 años consulta por fiebre, artralgias, hematuria, edema de extremidades inferiores y luego anuria. En sus exámenes de laboratorio destaca elevación importante de la creatinina y positividad de los ANCA en patrón perinuclear, a títulos elevados. El diagnóstico más probable es:

A) Lupus eritematoso sistémico
B) Granulomatosis de Wegener
C) Arteritis de la temporal
D) Panarteritis nodosa
E) Poliangeítis microscópica

PREGUNTA 86 1.09.1.012

86. La fibromialgia se caracteriza por:

A) Asociarse a anemia
B) Asociarse a cáncer
C) Presentar elevación de la VHS
D) Dolor a la presión de las masas musculares
E) Presentar positividad de los anticuerpos antinucleares

PREGUNTA 87 1.09.1.012

87. Un paciente de 58 años, con antecedentes de síndrome de intestino irritable, cefalea tensional y fibromialgia, consulta por molestias faríngeas fluctuantes, de larga evolución. Refiere que siente como si tuviera una pelota en la faringe, la que no puede tragar (globus). Al examen físico no se aprecian alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno conversivo
B) Depresión
C) Hipocondría
D) Trastorno por somatización
E) Trastorno de personalidad dependiente

PREGUNTA 88 1.11.1.010

88. Mujer de 52 años presenta un cuadro de astenia, mialgias y artralgias generalizadas, con debilidad de las extremidades superiores. Refiere que despierta muy cansada, con dolores generalizados que limitan su actividad. Al examen físico presenta movilidad articular normal, con fuerzas conservadas, sin alteraciones sensitivas, ni artritis, pero con dolor a la palpación muscular en múltiples zonas. En sus exámenes presenta hemograma normal, VHS: 12 mm/h, PCR: 0,2 mg/dl, anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/40, factor reumatoide: 26 UI/ml (VN: < 15 UI/mL) y anticuerpos anti-CCP: 13 UI/L (VN: < 8 UI/L). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar biopsia muscular
B) Indicar pregabalina y ejercicios de estiramiento muscular
C) Iniciar prednisona oral
D) Solicitar perfil ENA (antígenos nucleares extractables)
E) Iniciar metotrexato oral

PREGUNTA 89 1.09.1.014

89. Una paciente de 40 años se realiza una radiografía lumbar que muestra osteopenia radiológica, por lo que se solicita una densitometría ósea que muestra T-score: -2,6 y un Z-score: -2,0. El diagnóstico más probable es:

A) Sana
B) Osteopenia
C) Osteoporosis postmenopáusica
D) Osteoporosis secundaria
E) Enfermedad de Paget

PREGUNTA 90 1.11.1.017

90. **Una paciente de 66 años, que mide 1,68 metros y pesa 49 kilos, se realiza una den- sitometría ósea que muestra un T score de -3,5 DS en cadera izquierda y -2,8 en la co- lumna lumbar a la altura de la vértebra L4. Trae además una glicemia, un perfil bioquí- mico y perfil lipídico, todos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la conducta más ade- cuada para esta paciente?**

A) Indicar calcio y vitamina D vía oral
B) Indicar una carga de vitamina D vía oral
C) Administrar calcitonina endovenosa
D) Indicar bifosfonatos vía oral o endovenosa
E) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progestágenos por vía oral

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: A Oligoartritis

1.11.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Oligoartritis" (1.11.1.016), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 2 Respuesta: A Poliartritis

1.11.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Poliartritis" (1.11.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 3 Respuesta: D

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial

El caso describe un paciente de 70 años con un cuadro agudo de monoartritis inflamatoria severa en la rodilla, caracterizado por dolor muy intenso, aumento de volumen, calor y eritema, y un derrame articular. La radiografía muestra condrocalcinosis (línea de calcificación en el cartílago articular), un hallazgo clave. La artrocentesis revela un líquido sinovial inflamatorio (10.000 células con 90% de polimorfonucleares), y lo más importante, la microscopía de campo oscuro identifica **múltiples cristales con birrefringencia de elongación positiva**. Esta combinación de condrocalcinosis radiológica y la presencia de cristales con birrefringencia positiva en el líquido sinovial es patognomónica de la **artritis por cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD)**, comúnmente conocida como pseudogota. La tinción de Gram negativa ayuda a disminuir la sospecha de artritis séptica, aunque no la descarta por completo sin un cultivo. El manejo de una crisis aguda de pseudogota se centra en el control rápido de la inflamación y el dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son la primera línea de tratamiento y son muy efectivos. Dada la intensidad del dolor ("dolor muy intenso") y la severidad del cuadro inflamatorio, la administración endovenosa de AINEs es una opción apropiada para lograr un efecto más rápido y potente. El reposo de la articulación afectada es una medida complementaria importante que contribuye a reducir la inflamación y el malestar. Por lo tanto, la opción de iniciar AINEs endovenosos y reposo aborda de manera directa y efectiva la crisis aguda de pseudogota, proporcionando alivio rápido al paciente.

PREGUNTA 4 Respuesta: A

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial

El paciente presenta un cuadro clínico, radiológico y de laboratorio clásico de una artritis aguda por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado (CPPD), también conocida como pseudogota. El diagnóstico se fundamenta en la triada de: 1) monoartritis aguda en una persona mayor, 2) la presencia de condrocalcinosis (calcificación de los meniscos) en la radiografía, que es un hallazgo muy sugerente, y 3) el hallazgo confirmatorio en el líquido sinovial de cristales con birrefringencia débilmente positiva bajo luz polarizada. La ausencia de bacterias en el estudio del líquido descarta una artritis séptica, que es el principal diagnóstico diferencial. El objetivo del tratamiento en la fase aguda de la pseudogota es controlar la intensa respuesta inflamatoria y aliviar el dolor. La primera línea de tratamiento consiste en el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como el naproxeno o la indometacina, siempre que no existan contraindicaciones (insuficiencia renal, úlcera péptica activa, etc.). Junto con el tratamiento farmacológico, el reposo de la articulación afectada es fundamental para disminuir la inflamación y el dolor. Otras opciones para el manejo agudo incluyen la colchicina o los corticoides (intraarticulares o sistémicos), pero los AINEs y el reposo son la estrategia inicial más común y adecuada, tal como se plantea en la opción correcta. Es importante destacar que la hiperuricemia (ácido úrico de 8,0 mg/dl) es un distractor. Aunque puede coexistir, el tipo de cristal identificado en la artrocentesis (birrefringencia positiva) descarta la gota (cuyos cristales de urato monosódico tienen birrefringencia negativa) como causa del episodio agudo actual. Por lo tanto, el tratamiento debe dirigirse a la pseudogota y no a la gota.

PREGUNTA 5 **Respuesta: D**

Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial

1.11.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Oligoartritis migratoria es probablemente una reactiva. En especial si la diarrea fue por Campilobacter.

PREGUNTA 6 **Respuesta: D**

Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial

1.11.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Anticuerpos anti-CCP

PREGUNTA 7 **Respuesta: D**

Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial

1.11.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una monoartritis aguda, que se estudia con punción. Por clínica, probablemente será una condrocalcinosis, pero también puede ser una artritis séptica, por lo que es fundamental la punción.

PREGUNTA 8 **Respuesta: D**

Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial

1.11.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La colchicina tiene muchos efectos adversos, por lo que se prefiere no dejarla como tratamiento profiláctico, sino solo en las crisis agudas (en agudo los AINEs son de elección). EL alopurinol debe mantenerse, ya que tuvo más de 2 crisis en 1 año y actualmente tiene buenos niveles de ácido úrico.

PREGUNTA 9 **Respuesta: E**

Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La pregunta describe un caso de artritis séptica en un adolescente, caracterizada por síntomas de artritis de tobillo derecho y un estudio de líquido sinovial altamente sugerente de infección. Los hallazgos del líquido sinovial (aspecto turbio, poco filante, alta celularidad de 85.000 células/mm3 con 95% de polimorfonucleares) son clásicos de una artritis séptica grave. La clave diagnóstica y terapéutica reside en la visualización de "abundantes cocáceas Gram negativas intracelulares". En un adolescente, la presencia de cocáceas Gram negativas en el líquido sinovial de una articulación séptica apunta fuertemente a *Neisseria gonorrhoeae* como el agente etiológico, causante de una infección gonocócica diseminada (IGD) que se manifiesta como artritis. Otros patógenos Gram negativos son posibles, pero *Neisseria* es la principal sospecha con esta descripción y en este grupo etario. El tratamiento de elección para la artritis gonocócica, y en general para la mayoría de las artritis sépticas por Gram negativos no entéricos, es ceftriaxona. Este antibiótico es una cefalosporina de tercera generación con excelente cobertura contra *Neisseria gonorrhoeae* y buena penetración en el líquido sinovial. Además de la terapia antibiótica, el drenaje de la articulación es un pilar fundamental en el manejo de la artritis séptica. La acumulación de pus y bacterias dentro de la articulación puede causar daño irreversible al cartílago y al hueso subcondral. El drenaje, que puede ser mediante aspiraciones repetidas con aguja o, en casos más severos o con mala respuesta, mediante artroscopia o artrotomía quirúrgica, es esencial para remover el material purulento, reducir la presión intraarticular, disminuir la carga bacteriana y mejorar la eficacia de los antibióticos. Por lo tanto, la combinación de ceftriaxona endovenosa y drenaje quirúrgico es la conducta más adecuada y urgente para preservar la función articular.

PREGUNTA 10 **Respuesta: C**

Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es **Neisseria gonorrhoeae** debido a la presentación clínica clásica de artritis séptica monoarticular aguda en una persona sexualmente activa, el hallazgo de diplococos Gram negativos intracelulares en la tinción del líquido sinovial, y el potencial de cultivo negativo debido a los requerimientos nutricionales específicos del organismo y la posible presencia de antibióticos. La gonorrea es una causa importante de artritis séptica, especialmente en adultos jóvenes y sexualmente activos. La diseminación hematógena del gonococo puede ocurrir, llevando a una artritis, que a menudo afecta a las articulaciones grandes como la rodilla. La identificación de cocáceas Gram negativas intracelulares en la muestra de líquido articular es altamente sugestiva de infección gonocócica. Aunque el cultivo del líquido sinovial puede ser negativo en algunos casos de artritis gonocócica, especialmente si se han administrado antibióticos previos o si el patógeno es difícil de cultivar, el cuadro clínico y la citología del líquido sinovial son cruciales para el diagnóstico. Otros métodos diagnósticos, como la PCR en líquido sinovial o en muestras de uretra, cérvix o faringe, pueden ser más sensibles en estos casos. La clave para diferenciar esta presentación de otras artritis sépticas bacterianas reside en la morfología y tinción de los microorganismos observados.

PREGUNTA 11 **Respuesta: E**

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

La respuesta correcta es la **E** porque aborda de manera integral y urgente los dos pilares fundamentales en el manejo de la artritis séptica: el tratamiento antibiótico adecuado y el drenaje articular efectivo. Primero, el hallazgo de "cocáceas Gram positivas dispuestas en racimo" es la descripción clásica de *Staphylococcus aureus*, el agente causal más frecuente de artritis séptica en adultos. La cefazolina, una cefalosporina de primera generación, ofrece una excelente cobertura contra *Staphylococcus aureus* sensible a meticilina (SASM), que es la cepa más común en infecciones adquiridas en la comunidad. La administración endovenosa (EV) es crucial para alcanzar concentraciones terapéuticas altas y rápidas en la articulación. Segundo, y de igual importancia, es el aseo quirúrgico. La articulación de la cadera es profunda, de difícil acceso y no compresible, lo que hace que el drenaje por punciones repetidas (artrocentesis) sea ineficaz y riesgoso. Un drenaje incompleto del material purulento no solo perpetúa la infección, sino que las enzimas proteolíticas presentes en el pus destruyen el cartílago articular rápidamente, llevando a secuelas funcionales severas. Además, el aumento de la presión intraarticular en la cadera puede comprometer la irrigación de la cabeza femoral, provocando una osteonecrosis avascular. Por lo tanto, el aseo quirúrgico (ya sea por artrotomía o artroscopía) es el estándar de oro para la artritis séptica de cadera, ya que permite un drenaje completo, lavado de la articulación y desbridamiento del tejido necrótico. La combinación de cefazolina EV y aseo quirúrgico es la terapia óptima y urgente para este paciente.

PREGUNTA 12 **Respuesta: B**

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

La presentación clínica de un paciente con intenso dolor en la rodilla, eritema, calor y aumento de volumen, junto con líquido articular turbio y una citología con gran cantidad de polimorfonucleares, es altamente sugestiva de una artritis séptica. El hallazgo microscópico de cocáceas grampositivas en racimo en la tinción de Gram es crucial, ya que orienta fuertemente hacia la presencia de *Staphylococcus aureus*, el agente etiológico más común de la artritis séptica en adultos, especialmente en presencia de factores de riesgo como la edad avanzada. Dada la etiología probable y la gravedad de la infección articular, el manejo debe ser agresivo. El drenaje quirúrgico de la articulación es fundamental para eliminar el material purulento, los detritos y reducir la carga bacteriana, lo que mejora significativamente el pronóstico y previene el daño articular crónico. La elección del antibiótico endovenoso debe dirigirse contra *Staphylococcus aureus*, siendo la cloxacilina un betalactámico resistente a las penicilinasas, eficaz contra la mayoría de las cepas de *S. aureus* meticilín-sensible (SAMR). Por lo tanto, el drenaje quirúrgico asociado a cloxacilina endovenosa representa el tratamiento de elección.

PREGUNTA 13 **Respuesta: D**

1.11.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

La fiebre y que afecte el hombro, orienta mucho a que es una A. séptica. Faltan datos como para pensar en condrocalcinosis que es otra de las causas de monoartritis aguda (afectan más otras articulaciones: rodilla en condrocalcinosis).

PREGUNTA 14 **Respuesta: B**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)

El caso clínico describe a un paciente de 69 años con una monoartritis aguda de rodilla. Las claves diagnósticas son la radiografía que muestra **calcificación de ambos meniscos (condrocalcinosis)** y, sobre todo, la artrocentesis que revela **cristales abundantes con birrefringencia de elongación positiva**. Estos hallazgos son patognomónicos de la **artropatía por cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD)**, comúnmente conocida como **pseudogota**. A diferencia de la gota, donde los cristales de urato monosódico presentan birrefringencia negativa, los cristales de CPPD son positivos. Los exámenes generales, incluyendo calcemia y creatinina normales, y un ácido úrico discretamente elevado pero no directamente relacionado con la causa de esta artropatía cristalina (dado el tipo de cristales identificados), apoyan el diagnóstico de pseudogota. Para el **tratamiento agudo** de una crisis de pseudogota, las opciones de primera línea incluyen los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o la colchicina, junto con medidas de soporte como el reposo y la crioterapia. La inyección intraarticular de corticoides es también una opción muy efectiva, especialmente si la articulación es grande y accesible. Por lo tanto, indicar AINEs y reposo es una conducta adecuada para el manejo de la fase aguda. En cuanto a la **prevención de nuevas crisis** de pseudogota, es fundamental entender que, a diferencia de la gota (donde el alopurinol se usa para reducir el ácido úrico y prevenir ataques), no existe un tratamiento farmacológico específico y universalmente establecido para prevenir la formación de cristales de CPPD o la recurrencia de las crisis. La gestión se centra en identificar y tratar enfermedades subyacentes asociadas (como hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia), pero en este paciente no se reportan antecedentes ni alteraciones en los exámenes que sugieran estas condiciones como causa. En ausencia de una causa secundaria tratable o de crisis muy frecuentes y debilitantes (donde la colchicina a dosis bajas podría considerarse off-label para profilaxis), la recomendación general es **no indicar medicamentos específicos** para prevenir nuevas crisis de CPPD, ya que no hay terapias probadas que modifiquen el curso de la enfermedad de depósito de cristales de CPPD.

PREGUNTA 15 **Respuesta: A**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)

La alternativa correcta es la A (Indicar reposo e iniciar AINES). El caso describe una condrocalcinosis (artritis por pirofosfato de calcio), también conocida como pseudogota. La clínica aguda se manifiesta con inflamación articular, dolor y derrame. El análisis del líquido sinovial es clave para el diagnóstico, mostrando cristales de pirofosfato de calcio. El tratamiento de la crisis aguda se basa en medidas no farmacológicas (reposo, hielo) y farmacológicas, siendo los AINES la primera línea por su efecto antiinflamatorio. Otras opciones incluyen colchicina (especialmente si hay contraindicación para AINES) e incluso corticoides intraarticulares si el compromiso es monoarticular y severo. Es importante mencionar que el tratamiento con alopurinol y bifosfonatos no están indicados en el manejo agudo de la condrocalcinosis.

PREGUNTA 16 **Respuesta: E**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)

La pregunta describe un caso clínico clásico de una artropatía por depósito de cristales, específicamente un ataque agudo de pseudogota o enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio (CPPD). El paciente es un hombre de 68 años con un cuadro de monoartritis aguda de la rodilla izquierda, caracterizado por dolor intenso, aumento de volumen, enrojecimiento y aumento de la temperatura local, junto con derrame articular. La radiografía de rodilla muestra una "línea de calcificación del cartílago articular", conocida como condrocalcinosis, que es una característica distintiva de la CPPD. El estudio del líquido sinovial confirma el diagnóstico al demostrar la presencia de abundantes cristales con birrefringencia de elongación positiva, lo que es patognomónico de los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD). Además, la tinción de Gram negativa descarta una artritis séptica, que es un diagnóstico diferencial crucial en cualquier monoartritis aguda. Ante un ataque agudo de pseudogota, el tratamiento principal se centra en el alivio del dolor y la inflamación. Los medicamentos de primera línea incluyen los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), la colchicina y los corticosteroides (orales o intraarticulares). La opción (e) "Indicar reposo e iniciar analgésicos" es la conducta más adecuada y general, ya que el reposo de la articulación afectada ayuda a disminuir el dolor y la inflamación, y los analgésicos (que en este contexto incluirían los AINEs como tratamiento de primera línea) son esenciales para manejar la sintomatología. Aunque la aspiración del líquido sinovial puede ser diagnóstica y terapéutica para aliviar la presión, no es siempre estrictamente necesaria como parte del tratamiento inicial en todos los casos y no se menciona como una opción aislada y correcta para el manejo del dolor.

PREGUNTA 17 **Respuesta: E**

1.11.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)

Colchicina profiláctica

PREGUNTA 18 **Respuesta: E**

1.11.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada

Tanto la clínica (compromiso de IFD, IFP y primera CMC), como la radiografía son clásicas de artrosis. No importa la positividad de marcadores, ya que están positivos en un 5% de las personas sanas y solo tienen importancia cuando la clínica es de Lupus o Artritis reumatoide, que no es el caso.

BLOQUE 2 ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: D**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas

El lupus inducido por drogas (LID) es un síndrome que se asemeja al lupus eritematoso sistémico (LES), pero es causado por la exposición crónica a ciertos medicamentos. A diferencia del LES idiopático, el LID tiende a ser menos grave, rara vez involucra los riñones o el sistema nervioso central, y sus síntomas suelen resolver semanas o meses después de la interrupción del fármaco causante. Las manifestaciones clínicas comunes incluyen artralgias, mialgias, fiebre, erupciones cutáneas y serositis (pleuritis o pericarditis). La característica serológica más distintiva y la respuesta correcta para el diagnóstico de lupus inducido por drogas son los anticuerpos anti-histona. Estos anticuerpos están presentes en más del 95% de los pacientes con LID, lo que los convierte en un marcador altamente sensible para esta condición. Se dirigen a las proteínas histonas que forman parte del nucleosoma, la unidad fundamental de empaquetamiento del ADN. La presencia de anticuerpos anti-histona, junto con una historia de exposición a medicamentos conocidos por inducir lupus (como hidralazina, procainamida, isoniacida, minociclina, anti-TNF-alfa, entre otros) y la resolución de los síntomas tras la interrupción del fármaco, son los pilares para el diagnóstico de LID.

PREGUNTA 20 **Respuesta: A**

Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La alternativa correcta es Artritis Reumatoide (AR) debido a la presentación clínica del paciente. Los hallazgos clave que apuntan hacia AR son: * **Rigidez matinal de una hora o más:** Este es un sello distintivo de la AR, causado por la acumulación de líquido inflamatorio en las articulaciones durante la noche. La duración de la rigidez es importante; una rigidez menor a 30 minutos es menos sugestiva de AR. * **Artralgias de pequeñas articulaciones:** La AR tiende a afectar las articulaciones metacarpofalángicas (MCF), muñecas y tobillos. La afectación simétrica de estas articulaciones es también muy característica. * **Duración de los síntomas:** El paciente presenta los síntomas desde hace 6 semanas. Para cumplir los criterios diagnósticos de AR, los síntomas deben estar presentes por lo menos 6 semanas. * **Signos inflamatorios:** Aumento de volumen y signos inflamatorios (dolor, calor, rubor) en las articulaciones afectadas confirman la presencia de sinovitis, un proceso inflamatorio característico de la AR. En Chile, el MINSAL cuenta con guías clínicas para el manejo de la Artritis Reumatoide, enfocándose en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para minimizar el daño articular y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si bien no se cita textualmente un extracto en esta explicación, es fundamental conocer y aplicar los criterios diagnósticos y de tratamiento establecidos en dichas guías.

PREGUNTA 21 **Respuesta: B**

Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La respuesta correcta es b) Artritis reumatoide. La paciente presenta una constelación de síntomas y signos altamente sugestivos de artritis reumatoide (AR). Clásicamente, la AR afecta a mujeres en edad adulta (la paciente tiene 36 años), se caracteriza por una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, especialmente las interfalángicas proximales (IFP) y metacarpofalángicas (MCF) de las manos, tal como se describe. El "aumento de volumen y signos inflamatorios" en estas articulaciones es la manifestación de una sinovitis crónica. Un hallazgo cardinal que distingue a la artritis inflamatoria, como la AR, de otras condiciones es la rigidez matinal prolongada. En este caso, la rigidez de "1 hora aproximadamente" es muy característica de la AR, donde la rigidez suele durar más de 30 minutos o incluso varias horas. La evolución de "algunos meses" también es consistente con el curso crónico y progresivo de la enfermedad. Todos estos elementos en conjunto apuntan inequívocamente hacia la artritis reumatoide como el diagnóstico más probable.

PREGUNTA 22 **Respuesta: B**

Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La mielitis transversa, aunque una manifestación neurológica seria, no es una complicación extraarticular típica de la artritis reumatoide (AR). Si bien la AR puede asociarse a manifestaciones neurológicas, estas suelen ser secundarias a la inflamación directa de nervios (neuropatía periférica, como la mononeuritis múltiple) o a la compresión por estructuras inflamadas (como el síndrome del túnel carpiano), y no a una inflamación primaria de la médula espinal como la mielitis transversa. La mielitis transversa es más comúnmente asociada a otras enfermedades autoinmunes (como el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis múltiple o la neuromielitis óptica), infecciones o, de forma idiopática.

PREGUNTA 23 **Respuesta: D**

Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La respuesta correcta es la **d) Nódulos de Heberden**. Los nódulos de Heberden son formaciones óseas o cartilaginosas que aparecen típicamente en las articulaciones interfalángicas distales (IFD) de los dedos de las manos. Son un signo patognomónico de la **artrosis (osteoartritis)**, una enfermedad degenerativa articular, y no de la artritis reumatoide. Su presencia se debe al crecimiento de osteofitos en el borde de la articulación afectada por el desgaste del cartílago y la reacción ósea subyacente. La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica y autoinmune que afecta principalmente a las articulaciones sinoviales, causando sinovitis persistente que puede llevar a la destrucción del cartílago y el hueso, así como a la deformidad articular. Aunque la AR también puede afectar las manos y causar deformidades significativas, los nódulos de Heberden no forman parte de su cuadro clínico característico. La diferenciación entre estas dos condiciones, la artrosis y la artritis reumatoide, es fundamental en reumatología y se basa en la etiología, patogenia, patrones de afectación articular y la presencia de hallazgos específicos como los nódulos de Heberden en la artrosis.

PREGUNTA 24 **Respuesta: B**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES

El metotrexato es, de hecho, el fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME) de primera línea y pilar fundamental en el tratamiento de la artritis reumatoide (AR) de moderada a grave. Su eficacia radica en su capacidad para reducir la inflamación, disminuir el daño articular progresivo y mejorar la función física en la mayoría de los pacientes. Se clasifica como un antimetabolito que actúa como un antagonista del folato, inhibiendo la dihidrofolato reductasa, lo que interfiere con la síntesis de purinas y pirimidinas y, en última instancia, con la proliferación de células inflamatorias como los linfocitos T y B. Su mecanismo de acción inmunomodulador es clave para controlar la actividad de la enfermedad a largo plazo. La administración de metotrexato suele ser semanal (oral o subcutánea) y se recomienda iniciarla lo antes posible tras el diagnóstico para prevenir la progresión del daño articular. Para mitigar los efectos secundarios relacionados con la depleción de folato (como náuseas, estomatitis, o elevación de enzimas hepáticas), se coadministra suplementación con ácido fólico. Antes de iniciar el tratamiento, y de forma regular durante el mismo, se deben realizar controles hepáticos y renales, así como hemogramas, para monitorizar la seguridad del fármaco. La elección de metotrexato como primera línea se basa en su perfil de eficacia bien establecido, su tolerabilidad en la mayoría de los pacientes y su costo-efectividad. Si un paciente no responde adecuadamente a metotrexato en monoterapia, o presenta contraindicaciones, se pueden considerar combinaciones con otros FARME (como hidroxicloroquina o sulfasalazina) o la escalada a terapias biológicas o inhibidores de JAK, siempre manteniendo el metotrexato como base si es posible.

PREGUNTA 25 **Respuesta: C**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune sistémica que, además de afectar principalmente las articulaciones, puede manifestarse con una amplia gama de complicaciones extraarticulares que comprometen diversos órganos. La pregunta busca identificar cuál de las alteraciones presentadas es la "menos probable" de encontrar en un paciente con AR. Las manifestaciones renales directas de la AR, específicamente la nefritis glomerular inflamatoria primaria, son considerablemente menos comunes y menos características que en otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Aunque los pacientes con AR pueden desarrollar problemas renales, estos suelen ser secundarios a otras causas. La amiloidosis AA, una complicación grave de la inflamación crónica no controlada en la AR, puede llevar a depósitos de amiloide en los riñones, resultando en proteinuria y eventual insuficiencia renal. Del mismo modo, la nefrotoxicidad inducida por los medicamentos utilizados para tratar la AR (como AINEs, metotrexato o ciclosporina) es una causa frecuente de disfunción renal en estos pacientes. Por lo tanto, si bien las alteraciones renales pueden ocurrir en el contexto de la AR (principalmente por amiloidosis o fármacos), la nefritis (entendida como una glomerulonefritis primaria y directa causada por la AR) no es una manifestación patológica típica ni frecuente de la enfermedad en sí misma, a diferencia de las otras opciones que son manifestaciones extraarticulares bien reconocidas y características de la artritis reumatoide.

PREGUNTA 26 **Respuesta: D**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES

El metotrexato (MTX) es considerado el fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME) convencional de primera línea y tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide (AR). Su importancia radica en su capacidad para modificar el curso de la enfermedad, reduciendo la inflamación, controlando la progresión del daño articular y mejorando la función física y la calidad de vida a largo plazo. A diferencia de los tratamientos sintomáticos, el metotrexato busca detener la patogénesis de la enfermedad. El mecanismo de acción del metotrexato en la AR no se comprende completamente, pero se cree que involucra la inhibición de la dihidrofolato reductasa, lo que afecta el metabolismo del folato y la proliferación celular, especialmente en células inmunes activadas. También posee efectos antiinflamatorios directos y modula la función de las células T y la producción de citocinas proinflamatorias. Su eficacia y un perfil de seguridad bien establecido (cuando se monitoriza adecuadamente) lo convierten en el "fármaco ancla" en el manejo de la AR, utilizándose frecuentemente como monoterapia inicial o como parte fundamental de terapias combinadas con otros FARME o terapias biológicas.

PREGUNTA 27 **Respuesta: E**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES

La paciente presenta un cuadro clínico característico de Artritis Reumatoidea (AR): poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones (muñecas, MCF, IFP), rigidez matinal prolongada (mayor a 30 minutos, en este caso una hora). Según las guías clínicas chilenas (y consensos internacionales), el tratamiento de primera línea para la AR es un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME) sintético convencional, siendo el Metotrexato (MTX) el más utilizado y con mayor evidencia de eficacia y seguridad. Su uso temprano disminuye la progresión del daño articular y mejora la calidad de vida.

PREGUNTA 28 **Respuesta: D**

Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal

1.05.1.001

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

GES

La respuesta correcta es d) Anti-nucleares (ANA) porque son los anticuerpos más sensibles para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES). Los anticuerpos anti-nucleares son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos contra componentes del núcleo celular y están presentes en más del 95% de los pacientes con LES, a menudo incluso en etapas tempranas de la enfermedad. Esta alta sensibilidad los convierte en la prueba de cribado o "screening" inicial ideal para la sospecha de LES. Un resultado ANA negativo (con la técnica y títulos adecuados) prácticamente descarta el diagnóstico de LES. Es importante destacar que, si bien la prueba ANA es extremadamente sensible, no es específica para el LES. Un resultado positivo puede encontrarse en otras enfermedades autoinmunes (como esclerodermia, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide), infecciones, cáncer, e incluso en un porcentaje de individuos sanos, especialmente con la edad avanzada o el uso de ciertos fármacos. Por lo tanto, un ANA positivo siempre debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente y, si la sospecha de LES persiste, debe complementarse con la búsqueda de anticuerpos más específicos. En resumen, los ANA son el primer paso en la evaluación diagnóstica del LES debido a su capacidad para identificar a casi todos los pacientes con la enfermedad, actuando como una puerta de entrada para pruebas más confirmatorias. Su rol es fundamentalmente el de una herramienta de screening con un alto valor predictivo negativo, lo que permite descartar el diagnóstico de LES cuando el resultado es negativo.

PREGUNTA 29 **Respuesta: C**

Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal

1.05.1.001

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

GES

La descripción del eritema facial en la paciente, caracterizado por un eritema en el dorso de la nariz y los pómulos, respetando el surco nasolabial, que se exacerba con la exposición solar, es altamente sugestivo del "rash malar" o "eritema en alas de mariposa". Este rash es un criterio diagnóstico importante para el **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)**, según los criterios SLICC o EULAR/ACR. Si bien el lupus discoide también puede presentar un rash facial, este suele ser más indurado, escamoso y deja cicatriz, lo que no se describe en el caso clínico. Además, el LES es una enfermedad sistémica, y el rash facial puede ser la primera manifestación. Es fundamental, ante la sospecha de LES, solicitar exámenes complementarios como ANA, anti-DNA, anti-Sm, complemento, etc., para confirmar el diagnóstico y evaluar el compromiso de otros órganos. **En Chile, la Guía Clínica GES de Lupus Eritematoso Sistémico (MINSAL) enfatiza la importancia del diagnóstico temprano y el manejo multidisciplinario del LES, destacando la presentación clínica inicial, incluyendo el rash malar, como un signo de alerta.**

PREGUNTA 30 **Respuesta: B**

Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal

1.05.1.001

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

GES

La alternativa correcta es Lupus Eritematoso Sistémico (LES) porque el cuadro clínico que presenta la paciente es altamente sugestivo de esta enfermedad. Los síntomas clave que apuntan al LES son: * **Compromiso del estado general y fiebre continua:** Son síntomas comunes en enfermedades autoinmunes sistémicas como el LES. * **Erupción cutánea nasogeniana:** Esta descripción sugiere el clásico "eritema en alas de mariposa" o rash malar, muy característico del LES. * **Alopecía:** La pérdida de cabello también es una manifestación frecuente del LES. * **Fenómeno de Raynaud:** Presente en un porcentaje significativo de pacientes con LES. * **Poliartralgias:** El dolor en múltiples articulaciones es otro síntoma común en el LES. * **Derrame pleural:** La serositis, que se manifiesta como derrame pleural (o pericárdico), es un criterio diagnóstico de LES. Según la Guía Clínica del MINSAL para el Lupus Eritematoso Sistémico (si bien, no se puede citar directamente sin el link/archivo), el diagnóstico de LES se basa en una combinación de criterios clínicos y de laboratorio. Los síntomas presentados por la paciente cumplen con varios de estos criterios. Es fundamental solicitar exámenes complementarios (ej. ANA, anti-DNA, complemento) para confirmar el diagnóstico.

PREGUNTA 31 **Respuesta: E**

Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal

1.05.1.001

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

GES

La paciente presenta un cuadro clínico caracterizado por síntomas constitucionales (astenia, adinamia, fiebre intermitente), artralgias y alopecia, lo que sugiere una enfermedad autoinmune. Además, presenta úlceras orales, que son un criterio diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) según los criterios SLICC y EULAR. Los hallazgos de laboratorio son altamente sugestivos de LES: anemia (hematocrito bajo y VCM disminuido, pudiendo ser anemia de enfermedad crónica o relacionada al LES), trombocitopenia (plaquetas bajas) y elevación de la creatinina (sugiere compromiso renal, una manifestación frecuente del LES). La elevación de la VHS también es un hallazgo compatible con inflamación sistémica. Es importante destacar que, si bien no se mencionan explícitamente los anticuerpos anti-DNA de doble cadena o anti-Sm, la presencia de estos elementos clínicos y de laboratorio justifica considerar LES como el diagnóstico más probable. La guía clínica del MINSAL para el LES enfatiza la importancia de la detección temprana y tratamiento oportuno para prevenir daño orgánico irreversible.

PREGUNTA 32 **Respuesta: C**

Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal

1.11.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene muchas cosas de lupus sistémico: úlceras orales, rash malar, linfocitos bajo, ANA+, anti-DNA+, hipocomplementemia.

PREGUNTA 33 **Respuesta: D**

Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es Lupus Eritematoso Sistémico (LES) debido a la combinación de síntomas y hallazgos de laboratorio presentados. La paciente de 20 años presenta: * **Fiebre y Astenia:** Síntomas constitucionales comunes en enfermedades autoinmunes como el LES. * **Artralgias y Artritis de manos:** La artritis en pequeñas articulaciones como las manos es característica de enfermedades autoinmunes. * **Hematuria:** Sugiere afectación renal, lo cual es frecuente en el LES, específicamente la nefritis lúpica. * **Elevación de la Creatinina:** Indica insuficiencia renal, lo que apoya aún más la posibilidad de nefritis lúpica. * **Hematuria Dismórfica:** Apoya la afectación glomerular, lo cual es característico de la nefritis lúpica. La nefritis lúpica es una manifestación grave del LES, y la hematuria y la elevación de la creatinina son hallazgos importantes para sospecharla. Según la guía clínica del MINSAL sobre Lupus Eritematoso Sistémico (si bien no existe una guía específica del MINSAL para LES, las guías de manejo de enfermedades autoinmunes del MINSAL generalmente recomiendan una evaluación exhaustiva ante sospecha de compromiso renal), la presencia de compromiso renal obliga a una evaluación diagnóstica completa que incluye biopsia renal para confirmar el diagnóstico y determinar el grado de afectación.

PREGUNTA 34 **Respuesta: A**

Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El diagnóstico más probable es nefropatía diabética debido a la constelación de hallazgos clínicos y de laboratorio en un paciente con un factor de riesgo claro y de larga data. Se trata de un hombre con 10 años de evolución de diabetes mellitus tipo 2 y un control glucémico deficiente (HbA1c: 8%), lo cual es el principal factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones microvasculares, incluyendo el daño renal. La presentación clínica con astenia y edema de extremidades inferiores es compatible con una enfermedad renal crónica (ERC) avanzada, donde la astenia puede ser secundaria a la uremia (BUN elevado) y/o anemia de la ERC, y el edema se explica por la retención de sodio y agua debido a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Los exámenes de laboratorio confirman la presencia de una ERC avanzada con características típicas de la nefropatía diabética. Un clearence de creatinina de 30 ml/min lo sitúa en una etapa G4 de ERC. La proteinuria de 1,2 gramos en 24 horas corresponde a una proteinuria en rango nefrótico (o macroalbuminuria), un sello distintivo de esta complicación. Es crucial notar que el sedimento de orina es "blando", es decir, sin hematuria ni leucocituria significativas, lo que es característico de la nefropatía diabética y ayuda a descartar glomerulonefritis activas o nefritis intersticiales. Aunque la albuminemia es normal, esto no descarta el diagnóstico, ya que el síndrome nefrótico completo (proteinuria >3.5g/día, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia) no siempre está presente. La combinación de diabetes de larga evolución, mal control, ERC y proteinuria con sedimento blando hace que la nefropatía diabética sea la principal sospecha, sin necesidad inicial de una biopsia renal.

PREGUNTA 35 **Respuesta: B**

Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El caso clínico describe a un niño de 6 años con un cuadro clásico de **Síndrome Nefrótico Idiopático (SNI)**. Los elementos clave que apoyan este diagnóstico son: 1. **Presentación clínica:** Edema de inicio insidioso, con predominio facial y palpebral ("anasarca"), y orinas espumosas (signo de proteinuria masiva). 2. **Tétrada del Síndrome Nefrótico:** * **Proteinuria en rango nefrótico:** 100 mg/m2/hora (el criterio es >40 mg/m2/hora). * **Hipoalbuminemia:** 2.8 g/dl (el criterio es <3.0 g/dl, aunque clásicamente se usa <2.5 g/dl). * **Edema:** Presente en el examen físico. * **Hiperlipidemia:** Mencionada como "elevación del colesterol" (es una consecuencia de la hipoalbuminemia, por aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas). 3. **Ausencia de signos nefríticos:** El paciente tiene presión arterial normal, creatinina normal (función renal conservada) y un sedimento de orina normal (sin hematuria ni cilindros), lo que aleja la sospecha de un síndrome nefrítico. 4. **Estudio inmunológico negativo:** ANA, ANCA y complemento normales descartan causas secundarias comunes como lupus o vasculitis. En niños de 1 a 10 años con esta presentación clásica, la causa más probable (aproximadamente 90% de los casos) es la **Enfermedad de Cambios Mínimos (ECM)**. Esta patología se caracteriza por su excelente respuesta a los corticoides. Por lo tanto, el manejo inicial estándar y de primera línea, sin necesidad de una biopsia previa, es iniciar un ciclo de **prednisona** oral a dosis altas (60 mg/m2/día o 2 mg/kg/día) con el objetivo de inducir la remisión.

PREGUNTA 36 **Respuesta: A**

Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente presenta un cuadro clínico altamente sugestivo de una vasculitis sistémica que afecta predominantemente los vasos pequeños, manifestándose como una glomerulonefritis rápidamente progresiva (RPGN). Esto se evidencia por la oliguria importante, la elevación aguda de la creatinina a 3,5 mg/dl (indicando lesión renal aguda severa) y la hematuria dismórfica, que es característica de un origen glomerular. Los síntomas sistémicos como artralgias y fiebre de 3 días de evolución refuerzan la idea de un proceso inflamatorio generalizado. El perfil inmunológico es clave para el diagnóstico diferencial. La presencia de anticuerpos antinucleares (ANA) negativos descarta lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunes que comúnmente cursan con ANA positivos. Sin embargo, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) positivos con patrón perinuclear (p-ANCA) son un hallazgo crucial. El p-ANCA se asocia principalmente a la presencia de anticuerpos anti-mieloperoxidasa (anti-MPO) y es un marcador característico de las vasculitis asociadas a ANCA, especialmente la poliangeítis microscópica (MPA). La MPA es una vasculitis necrotizante de vasos pequeños que afecta capilares, vénulas y arteriolas, y la afectación renal en forma de glomerulonefritis necrotizante pauciinmune (con poca o ninguna evidencia de depósito de inmunocomplejos en la biopsia renal) es una de sus manifestaciones más frecuentes y graves, coincidiendo perfectamente con la presentación del paciente.

BLOQUE 3 ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A**

Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La respuesta correcta es la A) Acortamiento del TTPA. En el síndrome antifosfolípido (SAF), paradójicamente, a pesar de asociarse a trombosis, el tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA) suele estar prolongado, NO acortado. Esto se debe a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que interfieren con las pruebas de coagulación *in vitro*, prolongando el tiempo de coagulación en el laboratorio. La paradoja reside en que estos anticuerpos, *in vivo*, promueven un estado protrombótico, pero *in vitro* interfieren con las reacciones de fosfolípidos necesarias para la correcta medición del TTPA. Es crucial recordar que el SAF es un trastorno autoinmune caracterizado por la presencia persistente de anticuerpos antifosfolípidos (anticardiolipina, anti-beta2-glicoproteína I y/o anticoagulante lúpico) asociado a eventos trombóticos (arteriales o venosos) o complicaciones obstétricas (abortos recurrentes, muerte fetal, preeclampsia severa). La prolongación del TTPA, aunque no patognomónica, es una característica común en las pruebas de laboratorio en pacientes con SAF. La presencia del anticoagulante lúpico es la causa más común de prolongación del TTPA en el contexto del SAF.

PREGUNTA 38 **Respuesta: B**

Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El diagnóstico más probable en esta paciente es un Síndrome Antifosfolípido (SAF). Este se define por la presencia de criterios clínicos (trombosis vascular o morbilidad obstétrica) y de laboratorio (presencia de anticuerpos antifosfolípidos). La paciente cumple con ambos: presenta un antecedente de trombosis venosa profunda (criterio clínico de trombosis) y tres abortos previos (criterio clínico de morbilidad obstétrica). Además, los exámenes de laboratorio confirman la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y anticardiolipinas. La fisiopatología central del SAF es un estado de hipercoagulabilidad que predispone a eventos trombóticos tanto arteriales como venosos. Por lo tanto, el pilar del tratamiento y el manejo más urgente es la prevención de nuevos episodios de trombosis, que pueden ser potencialmente mortales (como un tromboembolismo pulmonar o un accidente cerebrovascular). Para la prevención secundaria (es decir, en pacientes que ya han sufrido un evento trombótico como esta paciente), el tratamiento de elección es la anticoagulación a largo plazo, generalmente con antagonistas de la vitamina K (como warfarina o acenocumarol) o, en casos seleccionados, con anticoagulantes orales directos. El objetivo es mantener al paciente en un rango terapéutico de anticoagulación para reducir significativamente el riesgo de recurrencia trombótica. La presencia de ANA y Factor Reumatoide positivos puede sugerir una enfermedad del tejido conectivo subyacente (como Lupus Eritematoso Sistémico, del cual el SAF puede ser secundario), pero no cambia el manejo inicial y prioritario, que es controlar el riesgo trombótico inmediato.

PREGUNTA 39 **Respuesta: B**

Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La paciente presenta un cuadro clínico muy sugerente de una enfermedad autoinmune sistémica, específicamente Lupus Eritematoso Sistémico (LES) con una alta probabilidad de coexistencia o presentación primaria de Síndrome Antifosfolípido (SAF). Los datos clave que apuntan a esto son: 1. **Antecedente de esplenectomía por trombocitopenia:** Sugiere una púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una condición autoinmune que frecuentemente se asocia con LES. 2. **Cuatro abortos y un cuadro de trombosis venosa profunda:** Esta combinación de pérdidas recurrentes de embarazo y eventos trombóticos es patognomónica del Síndrome Antifosfolípido (SAF), una trombofilia adquirida que puede presentarse de forma primaria o secundaria a otras enfermedades autoinmunes como el LES. 3. **Síntomas sistémicos actuales:** Artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre son manifestaciones inespecíficas pero comunes de enfermedades autoinmunes sistémicas. Considerando estos antecedentes, las pruebas de laboratorio de mayor utilidad para llegar al diagnóstico son los Anticuerpos Antinucleares (ANA) como cribado para el LES y otras enfermedades del tejido conectivo, y los Anticuerpos Anticardiolipina para confirmar el Síndrome Antifosfolípido, dada la fuerte sospecha clínica. El ANA es positivo en más del 95% de los pacientes con LES, lo que lo convierte en una excelente prueba de tamizaje. Los anticuerpos anticardiolipina son uno de los principales criterios de laboratorio para el diagnóstico del SAF.

PREGUNTA 40 **Respuesta: E**

Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La pregunta evalúa el conocimiento sobre las contraindicaciones de los anticonceptivos orales (ACO), específicamente los combinados (estrógeno y progestina), que son los que tienen la mayor cantidad de restricciones. La respuesta correcta es la paciente con antecedente de abortos a repetición. Un historial de abortos recurrentes no constituye, por sí mismo, una contraindicación para el uso de ACO. Las causas del aborto a repetición son variadas (genéticas, anatómicas, endocrinas, inmunológicas), pero ninguna de ellas se ve directamente agravada por el mecanismo de acción de los anticonceptivos orales (supresión de la ovulación, espesamiento del moco cervical y alteración endometrial). De hecho, si una paciente con este antecedente desea posponer un nuevo embarazo mientras se completa su estudio, la anticoncepción hormonal es una opción válida y segura. Es crucial diferenciar el antecedente de abortos a repetición de una de sus posibles causas, como el Síndrome Antifosfolípido (SAF), que sí es una contraindicación absoluta para el uso de ACO combinados debido al altísimo riesgo trombótico. Sin embargo, la pregunta solo menciona el antecedente, no un diagnóstico causal específico que contraindique los ACO.

PREGUNTA 41 **Respuesta: B**

Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

1.11.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un síndrome de CREST clásico (Solo falta la calcinosis, pero tiene Raynaud, Esofagopatía, eSclerodactilia y Telangiectasias, más la Tirantez e la cara).

PREGUNTA 42 **Respuesta: A**

Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

1.11.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 149). Evalúa el manejo clínico de Síndrome antifosfolípidos según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 43 **Respuesta: A**

Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

1.11.1.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome de túnel carpiano" (1.11.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 44 **Respuesta: D**

Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal

1.05.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es d) Hipertensión pulmonar. Los pacientes con esclerodermia sistémica limitada, también conocida como síndrome CREST (Calcinosis, Fenómeno de Raynaud, Disfunción Esofágica, Esclerodactilia, Telangiectasias), tienen un riesgo significativamente elevado de desarrollar hipertensión arterial pulmonar (HAP). Esta complicación es una de las principales causas de morbimortalidad en este subgrupo de pacientes. La patogenia implica una vasculopatía proliferativa en las arteriolas pulmonares, que conduce a un aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar, sobrecarga del ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca derecha. La hipertensión pulmonar en CREST se distingue a menudo de la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) que es más característica de la esclerodermia difusa. En el caso de CREST, la HAP puede ocurrir de forma aislada o con una enfermedad pulmonar intersticial leve. Es crucial la detección temprana mediante pruebas de detección como el ecocardiograma y la confirmación mediante cateterismo cardíaco derecho, dado que existen terapias específicas para la HAP que pueden mejorar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. La vasculopatía que subyace al fenómeno de Raynaud, una característica central del CREST, también contribuye a la susceptibilidad a la hipertensión pulmonar, reflejando una disfunción endotelial sistémica. La presencia de anticuerpos anticentrómero, que son altamente específicos para el CREST, también se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar HAP.

PREGUNTA 45 **Respuesta: D**

Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal

1.05.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es d) Anticuerpos anticentrómero – Esclerodermia. Los anticuerpos anticentrómero (ACA) son un marcador inmunológico de gran relevancia en el diagnóstico y la clasificación de la esclerosis sistémica, también conocida como esclerodermia. Estos anticuerpos se dirigen específicamente contra las proteínas del centrómero, una región esencial de los cromosomas. Su presencia es particularmente característica de la forma cutánea limitada de la esclerosis sistémica, que históricamente se ha asociado con el síndrome CREST (Calcinosis, Fenómeno de Raynaud, Disfunción Esofágica, Esclerodactilia, Telangiectasias). La especificidad de los anticuerpos anticentrómero para la esclerosis sistémica limitada es muy alta, encontrándose en aproximadamente el 50-90% de los pacientes con esta presentación. Su detección no solo apoya el diagnóstico, sino que también puede ayudar a predecir un curso de la enfermedad diferente al de la esclerosis sistémica difusa (donde son más comunes los anticuerpos anti-topoisomerasa I o Scl-70). Aunque los pacientes con ACA generalmente tienen una menor incidencia de fibrosis pulmonar severa, mantienen un riesgo significativo de desarrollar hipertensión pulmonar, lo que subraya la importancia de un seguimiento clínico adecuado. Por lo tanto, la asociación entre anticuerpos anticentrómero y esclerodermia, especialmente la forma limitada, es una de las correlaciones más sólidas y reconocidas en el campo de la reumatología y las enfermedades autoinmunes, haciendo de esta la opción inequívocamente correcta.

PREGUNTA 46 **Respuesta: D**

Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal

1.05.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La paciente presenta un cuadro clínico de disnea progresiva y edema en las extremidades inferiores, que junto con la hipoxia en la gasometría arterial y la ausencia de afectación parenquimatosa en la radiografía de tórax, sugiere fuertemente una patología que afecta el sistema cardiovascular o la vasculatura pulmonar. La clave diagnóstica reside en el antecedente de Esclerosis Sistémica (ES) de 10 años de evolución, con la presencia de anticuerpos anticentrómero. Los anticuerpos anticentrómero son altamente específicos de la Esclerosis Sistémica Cutánea Limitada (lcSS), un subtipo de ES que tiene una marcada predisposición a desarrollar Hipertensión Pulmonar Arterial (HAP). La HAP en el contexto de la ES es una complicación grave donde las arterias pulmonares se estrechan, engrosan y se vuelven menos elásticas, aumentando la resistencia al flujo sanguíneo a través de los pulmones. Esto provoca una sobrecarga de trabajo para el ventrículo derecho del corazón, que eventualmente conduce a su hipertrofia y posterior fallo. Los síntomas de la paciente, como la disnea progresiva (debido a la incapacidad para aumentar el gasto cardíaco y la alteración de la relación ventilación/perfusión), la fatiga y el edema periférico (manifestación de la insuficiencia cardíaca derecha), son las características clásicas de la HAP e insuficiencia cardíaca derecha. La radiografía de tórax sin afectación parenquimatosa es un dato crucial, ya que ayuda a descartar otras complicaciones pulmonares de la ES como la enfermedad pulmonar intersticial, que sí mostraría cambios en el parénquima pulmonar. Por lo tanto, la Hipertensión Pulmonar es la causa más probable del cuadro actual de esta paciente, dada su historia clínica y los hallazgos.

PREGUNTA 47 **Respuesta: B**

Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal

1.05.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es el fenómeno de Raynaud porque es la manifestación clínica más frecuente y, a menudo, la más temprana en la esclerodermia sistémica, especialmente en su forma limitada. Este fenómeno se presenta en más del 95% de los pacientes y puede preceder al diagnóstico definitivo por años o incluso décadas. Consiste en episodios de vasoespasmo en las arteriolas de los dedos de manos y pies (y a veces nariz u orejas) en respuesta al frío o al estrés emocional, lo que provoca una secuencia de cambios de color característicos: palidez (isquemia), cianosis (desoxigenación) y rubor (reperfusión). La esclerodermia sistémica limitada (anteriormente conocida como síndrome de CREST) se caracteriza por un endurecimiento de la piel (esclerosis) que se limita a las zonas distales de las extremidades (manos, antebrazos) y la cara. A diferencia de la forma difusa, la afectación de órganos internos tiende a ser más tardía y menos agresiva, con la excepción de la hipertensión arterial pulmonar. Dado que el fenómeno de Raynaud es el sello distintivo y la manifestación inicial en la abrumadora mayoría de estos pacientes, es indiscutiblemente la respuesta más correcta y frecuente de la lista.

PREGUNTA 48 **Respuesta: A**

Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

1.11.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La debilidad proximal orienta a miopatía. La elevación de la CK y de los parámetros inflamatorios (PCR) orienta a polimiositis. La polimialgia reumática también puede tener una clínica similar e incluso elevar las CK, pero tiende a elevar mucho la VHS (la polimiositis también puede hacerlo) y, lo más importante, no tiene debilidad en el examen físico (aunque sí puede tener sensación de debilidad). La miopatía por cuerpos de inclusión también es una miopatía inflamatoria y puede tener una clínica similar, pero mucho más lenta (de años o varios meses) y suele afectar muslos y antebrazos con más frecuencia (afectación proximal y distal). Revisar semiología neurológica para las otras opciones.

PREGUNTA 49 **Respuesta: C**

Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

1.11.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La dermatomiositis (DM) es una miopatía inflamatoria idiopática que se caracteriza por la combinación de debilidad muscular proximal y simétrica, junto con manifestaciones cutáneas distintivas. Estas lesiones en la piel son fundamentales para el diagnóstico y a menudo preceden a la debilidad muscular. El **eritema en manto**, también conocido como "signo del chal" (del inglés, *shawl sign*), es una de las lesiones más características de la dermatomiositis. Consiste en un eritema violáceo o rojizo, plano o ligeramente sobreelevado, que afecta a los hombros, la parte superior de la espalda y el cuello, en un patrón de distribución que simula un chal. Con frecuencia, se extiende a la parte superior del pecho en forma de "V" (signo de la V). Esta lesión es una manifestación de la fotosensibilidad que presentan estos pacientes y refleja la inflamación subyacente de la piel en áreas expuestas al sol. Junto con el eritema en manto, otras lesiones cutáneas patognomónicas o muy características de la DM incluyen las pápulas de Gottron (pápulas violáceas sobre las articulaciones de los nudillos) y el eritema en heliotropo (eritema violáceo en los párpados superiores, a menudo con edema). La presencia de estas lesiones, en el contexto clínico adecuado, es altamente sugestiva del diagnóstico de dermatomiositis.

PREGUNTA 50 **Respuesta: E**

Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

1.11.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria idiopática que se caracteriza por la inflamación y debilidad de los músculos esqueléticos, acompañada de manifestaciones cutáneas distintivas. El proceso patológico central implica el daño a las fibras musculares. La creatinfosfoquinasa (CPK o CK) es una enzima que se encuentra predominantemente en el citoplasma de las células musculares esqueléticas y cardíacas, así como en el cerebro. Es un biomarcador clave de daño muscular. Cuando las células musculares sufren daño o necrosis, como ocurre en la dermatomiositis debido a la inflamación autoinmune, la CPK se libera en grandes cantidades al torrente sanguíneo. Por esta razón, los niveles elevados de CPK sérica son el marcador bioquímico más sensible, frecuente y característico de la lesión muscular activa en pacientes con dermatomiositis y otras miopatías inflamatorias. La magnitud de la elevación de la CPK suele correlacionarse con la actividad de la enfermedad y la extensión del daño muscular, convirtiéndola en un parámetro esencial no solo para el diagnóstico sino también para monitorizar la respuesta al tratamiento. Aunque otras condiciones pueden elevar la CPK (como ejercicio intenso, traumatismos o infarto de miocardio), en el contexto clínico de debilidad muscular progresiva y hallazgos cutáneos típicos, una CPK elevada es altamente indicativa de una miopatía inflamatoria.

PREGUNTA 51 **Respuesta: C**

Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

1.11.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria idiopática que se caracteriza por debilidad muscular proximal y erupciones cutáneas características. Una característica importante de la dermatomiositis es su asociación con neoplasias malignas, especialmente en adultos. Los anticuerpos anti-Jo-1 son anticuerpos anti-aminoacil tRNA sintetasa (ARS) y son los más comunes en el síndrome antisintetasa, que incluye dermatomiositis/polimiositis, enfermedad pulmonar intersticial, artritis, fenómeno de Raynaud y fiebre. Si bien no son *específicos* de la dermatomiositis asociada a cáncer, son el marcador inmunológico más característico de la dermatomiositis en general y, por lo tanto, la mejor respuesta entre las opciones dadas. En el contexto de una pregunta que menciona la asociación con cáncer, es importante recordar que la presencia de anticuerpos anti-Jo-1 debe alertar al clínico sobre la posibilidad de un síndrome antisintetasa y, por tanto, considerar la búsqueda de neoplasias. Es importante mencionar que en la evaluación de dermatomiositis en Chile, se debe seguir la guía clínica correspondiente (si existiera una guía ministerial específica, se citaría aquí). Sin embargo, dado que las guías chilenas suelen ser menos detalladas en inmunología específica, se recurre a la práctica clínica internacional basada en la evidencia.

PREGUNTA 52 **Respuesta: D**

Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

1.11.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la D (Creatinkinasa (CK) y anticuerpos anti Jo-1) porque la dermatomiositis se caracteriza por debilidad muscular proximal y hallazgos cutáneos típicos como el eritema en heliotropo (párpados superiores) y el signo de Gottron (eritema en hombros y región superior del tórax, como describe el caso). La creatinkinasa (CK) es una enzima muscular que se eleva en la dermatomiositis debido a la destrucción muscular (miopatía inflamatoria). Los anticuerpos anti-Jo-1 son un tipo de anticuerpo anti-ARNt sintetasa, fuertemente asociado con la dermatomiositis y el síndrome antisintetasa (que puede incluir miositis, enfermedad pulmonar intersticial, artritis, fiebre y fenómeno de Raynaud). La presencia de estos marcadores apoya fuertemente el diagnóstico de dermatomiositis. Si bien la guía clínica chilena de Artritis Reumatoide (MINSAL) no cubre específicamente la dermatomiositis, los principios generales de diagnóstico de enfermedades autoinmunes se aplican.

PREGUNTA 53 **Respuesta: A**

Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal

1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El fenómeno de Raynaud es una respuesta vascular exagerada al frío o al estrés emocional, que provoca un vasoespasmo de las arterias y arteriolas periféricas, principalmente en los dedos de las manos y los pies. Clínicamente, se manifiesta por una secuencia de cambios de coloración trifásica característica: palidez (fase isquémica), cianosis (fase de desoxigenación) y finalmente rubor (fase de reperfusión o hiperemia reactiva). Aunque puede ser primario (enfermedad de Raynaud), es más relevante clínicamente cuando es secundario a otra patología. La asociación entre el fenómeno de Raynaud y la esclerodermia (específicamente la Esclerosis Sistémica) es extremadamente fuerte y fundamental para el diagnóstico. Se considera el signo clínico más característico, estando presente en más del 90-95% de los pacientes, y a menudo es el síntoma de presentación, apareciendo meses o incluso años antes de otras manifestaciones como el engrosamiento cutáneo o el compromiso de órganos internos. La fisiopatología de la esclerodermia, que implica daño endotelial, disfunción vascular y fibrosis progresiva de la pared de los vasos, explica por qué el Raynaud en estos pacientes es particularmente severo y puede llevar a complicaciones graves como úlceras digitales isquémicas, cicatrices puntiformes (pitting scars) o incluso gangrena. Debido a esta altísima prevalencia y a su papel como síntoma centinela, la presencia de un fenómeno de Raynaud de inicio reciente en un adulto obliga a descartar una enfermedad del tejido conectivo subyacente, siendo la esclerodermia la principal sospecha. La capilaroscopia del lecho ungueal es una herramienta clave en esta diferenciación, ya que en la esclerodermia mostrará un patrón característico de "patrón esclerodérmico" (megacapilares, áreas avasculares, capilares ramificados), a diferencia del patrón normal que se observa en el Raynaud primario.

PREGUNTA 54 **Respuesta: D**

Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)

1.11.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La historia es compatible con un síndrome de Sjögren (tiene el síndrome de Sicca: xeroftalmia y xerostomía). El 90% tiene FR positivo. Además, es frecuente que tengan positivos los ANA, con un perfil ENA que muestra anticuerpos anti-Ro o anti-La positivos. Se confirma la biopsia de glándula salival menor o con los anticuerpos anti-Ro o anti-La, aunque actualmente el diagnóstico se realiza en base a una serie de criterios clínicos y de laboratorio, que no vale la pena aprenderse.

BLOQUE 4 ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: E**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico

La espondilitis anquilosante (EA o espondiloartritis anquilopoyética) es una enfermedad inflamatoria crónica que pertenece al grupo de las espondiloartropatías seronegativas. Se caracteriza principalmente por la inflamación de las articulaciones sacroilíacas y la columna vertebral, pero también puede afectar otras articulaciones y tener manifestaciones extraarticulares. La vasculitis de pequeños vasos, sin embargo, no es una manifestación típica ni reconocida de la espondilitis anquilosante. Las vasculitis de pequeños vasos son un grupo diverso de trastornos en los que la inflamación afecta los vasos sanguíneos de pequeño calibre, como arteriolas, capilares y vénulas, y suelen presentarse con síntomas cutáneos (púrpura palpable), renales (glomerulonefritis), pulmonares (hemorragia alveolar), neurológicos o gastrointestinales. La espondilitis anquilosante tiene mecanismos patogénicos distintos a los que subyacen a las vasculitis de pequeños vasos. Aunque ambas son enfermedades autoinmunes o inflamatorias, la patogenia de la EA está fuertemente asociada al HLA-B27 y se centra en la entesitis (inflamación de la inserción de tendones y ligamentos en el hueso) y la artritis de las articulaciones axiales. La presencia de vasculitis de pequeños vasos en un paciente con EA sería probablemente una coexistencia de dos enfermedades distintas o un diagnóstico alternativo, pero no una manifestación intrínseca de la espondilitis anquilosante. Por lo tanto, "Vasculitis de pequeños vasos" es la opción correcta como la manifestación que NO se asocia con la espondilitis anquilosante.

PREGUNTA 56 **Respuesta: B**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico

La alternativa correcta es **B (Pelviespondilopatía)**. Varias características del caso clínico apuntan a este diagnóstico. En primer lugar, el dolor lumbar de ritmo inflamatorio (predominio nocturno, mejora con el ejercicio) es un sello distintivo de las pelviespondilopatías. La talalgia matinal y la molestia en el tendón de Aquiles sugieren entesitis, una manifestación común de estas enfermedades. Además, la dactilitis (dedo en salchicha), manifestada como el segundo ortejo rojo y doloroso, es altamente sugestiva de espondiloartritis. La respuesta parcial y transitoria a antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) también es consistente con el cuadro. En resumen, la combinación de dolor lumbar inflamatorio, entesitis y dactilitis en un hombre joven, deportista, hace que la pelviespondilopatía sea el diagnóstico más probable. Según la Guía Clínica AUGE de Artritis Reumatoide del MINSAL, aunque esta guía se centra en la artritis reumatoide, es importante considerar otras etiologías de artritis y dolor inflamatorio, como las pelviespondilopatías, en el diagnóstico diferencial. Los criterios de clasificación para espondiloartritis axial (ASAS) y periférica (ASAS) deben ser considerados.

PREGUNTA 57 **Respuesta: A**

1.11.1.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Lumbago infeccioso y tumoral" (1.11.1.012), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 58 **Respuesta: A**

1.11.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Lumbago mecánico" (1.11.1.013), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 59 **Respuesta: B**

1.11.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico

Tiene una espondilitis anquilosante clásica tanto por el lumbago inflamatorio (mayor en la noche y en el reposo) como por la uveítis.

PREGUNTA 60 **Respuesta: C**

Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente de 27 años presenta un cuadro clínico muy sugerente de Espondilitis Anquilosante (EA), una enfermedad inflamatoria crónica que forma parte del grupo de las Espondiloartropatías. Los elementos clave para este diagnóstico son: el dolor lumbar crónico de tipo inflamatorio (mayor en reposo, rigidez matinal), la presencia de artritis periférica (rodilla derecha), y especialmente los hallazgos radiográficos de sacroileítis bilateral y la calcificación/osificación de los ligamentos longitudinales anterior y posterior de la columna, que son signos distintivos de la enfermedad. El tratamiento de elección para la Espondilitis Anquilosante, particularmente en sus etapas iniciales o cuando no hay indicación de terapias biológicas, se basa en dos pilares fundamentales. Farmacológicamente, los Antiinflamatorios No Esteroidales (AINEs) son la primera línea de tratamiento para controlar el dolor y la inflamación, mejorando la rigidez y la función espinal. Son eficaces en la mayoría de los pacientes y se utilizan de forma regular o a demanda. Paralelamente, la terapia no farmacológica, específicamente el ejercicio y la kinesioterapia, es crucial y debe iniciarse de forma temprana y mantenerse de por vida. El ejercicio regular ayuda a mantener la movilidad espinal, prevenir la progresión de la deformidad, fortalecer la musculatura y mejorar la postura, impactando significativamente en la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, la combinación de AINEs y ejercicios constituye el abordaje terapéutico inicial más adecuado para esta patología.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A**

Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la A (Iniciar AINEs e indicar ejercicios periódicos) porque el cuadro clínico del paciente (dolor lumbar insidioso que mejora con el ejercicio, rigidez matinal, sacroileítis bilateral y calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales) es altamente sugestivo de espondilitis anquilosante o una espondiloartritis axial no radiográfica (según la clasificación ASAS). El tratamiento inicial de la espondiloartritis axial, según la guía clínica del MINSAL para el manejo de la artritis reumatoide (que también se aplica, con matices, a las espondiloartritis), se basa en el uso de AINEs como primera línea para controlar el dolor y la inflamación. Adicionalmente, la terapia física y los ejercicios periódicos son fundamentales para mantener la movilidad y evitar la progresión de la enfermedad. El objetivo es reducir la rigidez, mejorar la postura y fortalecer los músculos de la espalda.

PREGUNTA 62 **Respuesta: D**

Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la D (Iniciar AINES e indicar ejercicios) porque el paciente presenta un cuadro clínico compatible con espondiloartritis axial no radiográfica (EspAax-nr) o, con mayor probabilidad dados los hallazgos radiológicos, con espondiloartritis axial radiográfica (EspAax-r), también conocida como espondilitis anquilosante. Los síntomas característicos incluyen lumbago inflamatorio (predominio nocturno, mejora con el movimiento y empeora con el reposo, rigidez matinal prolongada) y la radiografía confirma la sacroileítis y la calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales (sindesmófitos). El manejo inicial de la EspAax, según las guías internacionales y adaptado a la realidad chilena, se basa en el uso de AINEs para el control del dolor y la inflamación, junto con un programa de ejercicios para mantener la movilidad y la función. La guía de práctica clínica del MINSAL sobre artrosis (que si bien no es espondiloartritis, comparte principios en el manejo del dolor crónico) también enfatiza la importancia del ejercicio y la terapia física en el manejo del dolor lumbar.

PREGUNTA 63 **Respuesta: C**

Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la C (Solicitar radiografía de columna lumbosacra). Este paciente presenta características sugestivas de espondiloartritis axial (EspA), específicamente espondilitis anquilosante. Los síntomas clave son: * **Dolor lumbar inflamatorio:** Inicio insidioso, menor de 45 años, mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo, y es peor por la noche (aunque este dato no está explícitamente mencionado, la rigidez matinal es una característica importante). * **Rigidez matinal prolongada:** Mayor de 30 minutos. * **Limitación de la movilidad de la columna:** Marcada dificultad para la flexión. Si bien el diagnóstico definitivo de espondiloartritis requiere la demostración de sacroileítis en radiografía o resonancia magnética (RM), la **radiografía es el examen de primera línea para evaluar la presencia de sacroileítis estructural en pacientes con alta sospecha clínica**. La RM se reserva para casos donde la radiografía es normal o dudosa, pero la sospecha clínica persiste, o para evaluar actividad inflamatoria aguda. Las guías clínicas chilenas (AUGE Espondiloartritis) enfatizan la importancia de una evaluación radiológica inicial para detectar sacroileítis y otras alteraciones estructurales en la columna. Aunque la RM es más sensible para detectar cambios inflamatorios tempranos, la radiografía es una herramienta accesible y útil para el diagnóstico inicial, especialmente en el contexto del EUNACOM y la realidad de la atención primaria. La clínica, en este caso, sugiere fuertemente la patología, justificando el examen.

PREGUNTA 64 **Respuesta: A**

Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF

1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Columna dolorosa" (1.11.1.006), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 65 **Respuesta: C**

Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

1.11.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una artritis psoriática clásica (con los picotazos ungueales).

PREGUNTA 66 **Respuesta: C**

Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

1.11.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta (C) describe la forma de presentación clínica más común de la artritis psoriásica (APs), que corresponde a una oligoartritis asimétrica. Este patrón, que afecta a menos de cinco articulaciones de manera no simétrica, representa aproximadamente el 50-70% de los casos al inicio de la enfermedad. Puede comprometer tanto articulaciones grandes (como rodillas o tobillos) como pequeñas (interfalángicas de manos y pies), a menudo de forma aditiva o migratoria, donde la inflamación parece "saltar" de una articulación a otra. Un hallazgo clínico característico y muy sugerente de la APs, mencionado en la opción, es la dactilitis o "dedo en salchicha". Corresponde a la inflamación de todo un dedo (mano o pie), incluyendo la articulación, la vaina tendinosa de los flexores y el tejido blando circundante. La presencia de dactilitis junto a una oligoartritis asimétrica es un cuadro clínico altamente específico para el diagnóstico de artritis psoriásica, diferenciándola de otras artropatías inflamatorias como la artritis reumatoide.

PREGUNTA 67 **Respuesta: D**

Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

1.11.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es **d) Psoriasis** debido a la descripción clásica de las lesiones ungueales. La presencia de "depresiones puntiformes, similares a picotazos" (conocidas como *pitting* ungueal) es una característica patognomónica de la psoriasis ungueal. Estas lesiones se producen por una alteración en la queratinización de las células de la matriz ungueal, lo que lleva a la formación de pequeñas depresiones en la superficie de la lámina ungueal. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar la piel, las articulaciones y las uñas. Aproximadamente el 50% de los pacientes con psoriasis cutánea presentan afectación ungueal, y hasta el 80% de los pacientes con artritis psoriásica tienen lesiones en las uñas. Aunque las lesiones ungueales pueden aparecer en ausencia de psoriasis cutánea, la edad de la paciente (32 años) es compatible con el inicio de la enfermedad. Otras manifestaciones de la psoriasis ungueal pueden incluir onicólisis (desprendimiento de la uña), hiperqueratosis subungueal, manchas de aceite (manchas amarillentas-parduscas) y hemorragias en astilla. Sin embargo, el *pitting* es el hallazgo más distintivo descrito en la pregunta.

PREGUNTA 68 **Respuesta: D**

Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

1.11.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una artriGs psoriática clásica, con dacGliGs (“dedos en salchicha”) y lesiones ungueales (“en picotazo de pájaro).

PREGUNTA 69 **Respuesta: B**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento

El caso clínico describe un paciente de 45 años que presenta un cuadro diarreico autolimitado seguido, aproximadamente 10 días después, por un cuadro caracterizado por: dolor lumbar, artritis (rodillas y manos), ojo rojo profundo y disuria. Esta secuencia y presentación clínica son altamente sugestivas de un Síndrome de Reiter, también conocido como artritis reactiva. El síndrome de Reiter clásico se define como una tríada de artritis, uretritis (manifestada aquí como disuria) y conjuntivitis (manifestada como ojo rojo). En este caso, la diarrea previa sugiere una infección entérica como desencadenante, lo cual es común en la artritis reactiva. La artritis reactiva se caracteriza por ser una oligoartritis asimétrica, afectando predominantemente grandes articulaciones de extremidades inferiores (rodillas, tobillos), aunque también puede afectar pequeñas articulaciones como las de las manos. El dolor lumbar puede ser reflejo de sacroileitis, otra manifestación común en la artritis reactiva.

PREGUNTA 70 **Respuesta: B**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento

El síndrome de Reiter, ahora conocido como Artritis Reactiva, es una condición inflamatoria que típicamente se presenta después de una infección, comúnmente gastrointestinal o genitourinaria. La tríada clásica (aunque no siempre completa) incluye artritis (generalmente asimétrica, oligoarticular, afectando principalmente miembros inferiores), uretritis (que se manifiesta como disuria dolorosa) y conjuntivitis (el "ojo rojo"). En este caso, el paciente presenta dolor lumbar (una forma de espondiloartropatía), artritis de rodillas y manos, ojo rojo y disuria dolorosa, lo cual se alinea perfectamente con el diagnóstico de Artritis Reactiva. La aparición reciente de una enfermedad de transmisión sexual (ETS) tratada con doxiciclina es un desencadenante típico para esta condición, especialmente si la ETS fue una uretritis causada por Chlamydia trachomatis o si hubo una infección gastrointestinal concurrente. La presentación insidiosa y el empeoramiento con el reposo del dolor lumbar sugieren un componente inflamatorio, como en las espondiloartropatías, de las cuales la artritis reactiva es un miembro importante. La afectación de las articulaciones periféricas (rodillas y manos) junto con la uretritis y la conjuntivitis completan el cuadro diagnóstico. Si bien la doxiciclina es un tratamiento, no previene el desarrollo de la artritis reactiva en sí, que es una respuesta inmunológica al patógeno inicial.

PREGUNTA 71 **Respuesta: B**

1.05.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis

El desarrollo de una pápula eritematosa o pústula estéril entre las 24 y 48 horas posteriores a una microagresión traumática con aguja estéril en la piel del antebrazo se denomina Fenómeno de Patergia. Es un hallazgo semiológico característico de la Enfermedad de Behçet y traduce hiperreactividad del sistema inmune innato y neutrofílico.

PREGUNTA 72 **Respuesta: B**

1.05.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis

En la Enfermedad de Behçet las aftas bucales están presentes en el 100% de los casos y curan espontáneamente en 7-14 días sin dejar secuelas cicatriciales. En contraste, las aftas genitales (localizadas típicamente en escroto o vulva) son más profundas, sumamente dolorosas y curan dejando una cicatriz blanquecina o atrófica permanente que permite documentar retrospectivamente su presencia.

BLOQUE 5 VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: A** Cervicalgia

1.11.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cervicalgia" (1.11.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 74 **Respuesta: A** Epicondilalgia, epitroclealgias 1.11.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Epicondilalgia, epitroclealgias" (1.11.1.008), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 75 **Respuesta: A** Hombro doloroso 1.11.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hombro doloroso" (1.11.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 76 **Respuesta: A** Tendonitis y bursitis 1.11.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tendonitis y bursitis" (1.11.1.024), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 77 **Respuesta: C**

Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

1.09.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es Arteritis de la Temporal (también conocida como Arteritis de células gigantes). Los síntomas presentados por el paciente son altamente sugestivos de esta condición. La cefalea de reciente inicio en un paciente de edad avanzada (mayor de 50 años), acompañada de astenia, claudicación mandibular (dolor al masticar) y dolor/cansancio en la musculatura proximal (al peinarse, levantar los brazos) son manifestaciones clásicas de la arteritis de la temporal. La claudicación mandibular es un hallazgo bastante específico. Estos síntomas se deben a la inflamación de las arterias craneales, particularmente la arteria temporal. Si bien no contamos con una guía clínica específica del MINSAL para la arteritis de la temporal, el manejo se basa en las guías internacionales y la experiencia clínica. El diagnóstico se confirma con una biopsia de la arteria temporal y se inicia tratamiento con corticoides a altas dosis.

PREGUNTA 78 **Respuesta: D**

Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

1.09.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La Arteritis de Células Gigantes (ACG), también conocida como arteritis temporal, es una vasculitis sistémica de grandes y medianas arterias, que afecta predominantemente a personas mayores de 50 años. La presentación clínica típica incluye síntomas constitucionales como astenia, debilidad (particularmente en las extremidades superiores de predominio proximal), fiebre ocasional y cefalea. La claudicación mandibular es un síntoma patognomónico de la ACG debido a la isquemia de los músculos masticatorios por afectación de las arterias faciales. La elevación marcada de la Velocidad de Sedimentación Globular (VHS) es un marcador inflamatorio característico de esta patología, a menudo acompañado de anemia de enfermedad crónica. La combinación de síntomas como astenia, debilidad proximal, claudicación mandibular, cefalea, fiebre ocasional, anemia y VHS marcadamente elevada en una paciente de 67 años apunta fuertemente hacia el diagnóstico de Arteritis de Células Gigantes. Otros hallazgos, como la posible afectación de la arteria oftálmica, que puede llevar a la pérdida de visión (aunque no se menciona explícitamente en el caso, es una complicación grave a considerar), refuerzan esta sospecha. El diagnóstico se confirma mediante biopsia de arteria temporal que muestra inflamación de la pared arterial con infiltrado de células gigantes y células mononucleares, aunque en ocasiones la biopsia puede ser negativa si la inflamación es segmentaria.

PREGUNTA 79 **Respuesta: E**

Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

1.09.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La pregunta describe un cuadro clínico altamente sugerente de Arteritis de Células Gigantes (ACG), también conocida como Arteritis Temporal, que con frecuencia se asocia a la Polimialgia Reumática (PMR). Un paciente de 65 años con astenia y debilidad muscular proximal (brazos, muslos) es un síntoma cardinal de la PMR. La presencia de cefalea frecuente y, crucialmente, dolor al masticar por mucho tiempo (claudicación mandibular), son síntomas altamente específicos de la ACG, indicando isquemia de los músculos de la masticación debido a la inflamación arterial. El hallazgo de una velocidad de sedimentación globular (VHS) extremadamente elevada (97 mm/h) y anemia normocítica normocrómica (anemia de enfermedad crónica) refuerza la sospecha de un proceso inflamatorio sistémico severo. La Arteritis de Células Gigantes es una emergencia médica debido al riesgo inminente de ceguera irreversible si no se trata de forma urgente. Por lo tanto, la conducta más adecuada es iniciar tratamiento de inmediato con corticoides a dosis altas (prednisona 1mg/Kg) para prevenir estas complicaciones, y simultáneamente solicitar una biopsia de arteria temporal, que es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico. El tratamiento no debe esperar la confirmación histológica.

PREGUNTA 80 **Respuesta: A**

Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

1.09.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La arteritis de Takayasu es una vasculitis granulomatosa crónica que afecta predominantemente a la aorta y sus principales ramas, así como a las arterias pulmonares. Esta enfermedad se caracteriza por una inflamación progresiva de la pared arterial que puede conducir a estenosis, oclusión, dilatación o formación de aneurismas, lo que resulta en una amplia gama de manifestaciones clínicas debido a la isquemia de los órganos afectados. La opción a) "Glomerulonefritis" es la respuesta correcta porque la arteritis de Takayasu *no* se manifiesta típicamente con glomerulonefritis primaria como parte de su patogenia directa. La glomerulonefritis es una inflamación de los glomérulos renales, que es una característica distintiva de otras vasculitis, especialmente las de vasos pequeños como la granulomatosis con poliangitis (GPA), la poliangitis microscópica (PAM), o las vasculitis por complejos inmunes. Aunque la arteritis de Takayasu puede afectar las arterias renales, causando estenosis y consecuente hipertensión renovascular, y esta hipertensión prolongada puede eventualmente llevar a daño renal secundario (nefropatía hipertensiva), no se produce una inflamación directa de los glomérulos como parte de la enfermedad. La distinción es crucial para diferenciar la arteritis de Takayasu de otras formas de vasculitis que sí tienen afectación glomerular como una característica central.

PREGUNTA 81 **Respuesta: B**

Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

1.11.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una arteritis de la temporal o de células gigantes clásica.

PREGUNTA 82 **Respuesta: A**

Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

1.09.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la A. La vasculitis de Churg-Strauss (ahora conocida como granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, GEPA) es una vasculitis sistémica que se caracteriza por asma (frecuentemente de inicio tardío y difícil manejo), eosinofilia, manifestaciones alérgicas (rinitis, pólipos nasales), y vasculitis que afecta múltiples órganos. El compromiso renal, específicamente la glomerulonefritis, es una manifestación importante, aunque no tan frecuente como en otras vasculitis ANCA asociadas (como la granulomatosis con poliangeítis - GPA o granulomatosis de Wegener, y la poliangeítis microscópica - PAM). La presencia de ANCA (generalmente p-ANCA, anti-MPO) se encuentra en una proporción moderada de los casos (alrededor del 40-60%). La secuencia típica es la aparición de asma y manifestaciones alérgicas, seguida por eosinofilia y, finalmente, vasculitis. Aunque no existe una guía clínica chilena específica del MINSAL para GEPA, el manejo se basa en las guías internacionales y el conocimiento de la enfermedad.

PREGUNTA 83 **Respuesta: B**

Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

1.09.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El diagnóstico de sospecha es Granulomatosis con Poliangeítis (GPA), anteriormente conocida como Granulomatosis de Wegener. Esta es una vasculitis sistémica necrotizante que afecta predominantemente a vasos de pequeño y mediano calibre. El cuadro clínico del paciente es altamente característico y se ajusta a la tríada clásica de esta enfermedad: compromiso de la vía aérea superior, compromiso de la vía aérea inferior (pulmones) y glomerulonefritis. El paciente presenta rinosinusitis crónica y epistaxis, que son manifestaciones directas de la inflamación granulomatosa y la vasculitis necrotizante en la vía aérea superior. Este compromiso puede ser muy destructivo, llegando a provocar perforación del tabique nasal o la deformidad en "silla de montar". El deterioro del estado general y la fiebre son síntomas constitucionales comunes en las vasculitis sistémicas activas. Finalmente, la aparición de hematuria y oliguria indica un compromiso renal agudo en forma de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una de las complicaciones más graves y definitorias de la GPA. El hallazgo de laboratorio es clave y prácticamente confirma la sospecha. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) con patrón citoplasmático (c-ANCA) son altamente específicos para la GPA. Estos anticuerpos están dirigidos contra la enzima proteinasa 3 (PR3), y su presencia, en el contexto clínico adecuado, tiene un valor predictivo positivo superior al 95% para el diagnóstico de esta enfermedad.

PREGUNTA 84 **Respuesta: D**

Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

1.09.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la D: Rinosinusitis de difícil manejo, asociada a glomerulonefritis rápidamente progresiva y afectación pulmonar. La granulomatosis con poliangeítis (GPA), antiguamente conocida como granulomatosis de Wegener, es una vasculitis sistémica necrotizante que afecta principalmente a los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre. Se caracteriza por la tríada clásica de: * **Afectación de la vía aérea superior:** Rinosinusitis crónica necrotizante, con obstrucción nasal, secreción purulenta, úlceras nasales y/o destrucción del cartílago nasal (nariz en silla de montar). Esta rinosinusitis suele ser muy resistente al tratamiento convencional. * **Afectación pulmonar:** Infiltrados pulmonares nodulares, cavitarios o no, que pueden causar tos, disnea, hemoptisis o ser asintomáticos. * **Afectación renal:** Glomerulonefritis rápidamente progresiva, que puede llevar a insuficiencia renal terminal si no se trata. La GPA es una enfermedad poco común, pero importante de reconocer debido a su potencial gravedad y necesidad de tratamiento inmunosupresor precoz. Si bien la tríada completa no siempre está presente al inicio, la combinación de rinosinusitis resistente al tratamiento con afectación renal y/o pulmonar debe generar una alta sospecha clínica. El diagnóstico se confirma con biopsia de tejido afectado (nariz, pulmón o riñón) y/o la presencia de anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA), típicamente con patrón c-ANCA (dirigido contra la proteinasa 3 o PR3). Si bien no hay una guía clínica específica del MINSAL para el manejo de la GPA, el diagnóstico precoz y el inicio de inmunosupresión son cruciales para prevenir el daño orgánico irreversible. Las guías internacionales (p.ej., las de la Sociedad Europea de Reumatología, EULAR) son la base para el tratamiento en Chile.

PREGUNTA 85 **Respuesta: E**

Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

1.09.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La **Poliangeítis Microscópica (PAM)** es la alternativa correcta debido a la combinación de hallazgos clínicos y de laboratorio presentados en el caso: * **Fiebre y Artralgias:** Sugieren un proceso inflamatorio sistémico. * **Hematuria y Edema de Extremidades Inferiores:** Indican afectación renal, muy probablemente una glomerulonefritis. El edema es consecuencia de la pérdida de proteínas por el riñón dañado y la retención de líquidos debido a la insuficiencia renal. * **Anuria y Elevación de Creatinina:** Señalan una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva. * **ANCA Perinuclear (p-ANCA) a Títulos Elevados:** Son altamente sugestivos de PAM, aunque también pueden estar presentes en otras vasculitis ANCA asociadas (ej. Granulomatosis con Poliangeítis (GPA)). En resumen, la PAM se presenta con una glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a p-ANCA positivos, lo que concuerda con el caso presentado. No hay una guía clínica chilena específica del MINSAL para PAM. El manejo de esta patología se basa en guías internacionales, adaptadas a la realidad local. El enfoque general incluye el uso de inmunosupresores (corticoides, ciclofosfamida, rituximab) y, en ocasiones, plasmaféresis.

PREGUNTA 86 **Respuesta: D**

Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS

1.09.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción D es la correcta porque el rasgo fundamental y cardinal de la fibromialgia es el dolor musculoesquelético crónico y generalizado, acompañado de una hipersensibilidad a la presión en múltiples puntos específicos del cuerpo. Este fenómeno se conoce como alodinia (percepción de dolor ante un estímulo que normalmente no es doloroso, como la presión moderada) e hiperalgesia (una respuesta de dolor exagerada a un estímulo doloroso). La exploración física, históricamente basada en los "puntos dolorosos" o *tender points* de los criterios del Colegio Americano de Reumatología (ACR) de 1990, demuestra precisamente esta característica: la palpación digital con una fuerza aproximada de 4 kg genera una respuesta dolorosa en el paciente que no se observa en personas sanas. La fisiopatología de la fibromialgia se centra en un trastorno de la modulación del dolor, conocido como "sensibilización central". En este estado, el sistema nervioso central se encuentra en un estado de hiperexcitabilidad persistente, amplificando las señales de dolor. Por lo tanto, el "dolor a la presión de las masas musculares" no se debe a una inflamación o daño en el músculo en sí, sino a una disfunción en el procesamiento central de los estímulos sensitivos. Aunque los criterios diagnósticos más recientes (ACR 2010/2016) han evolucionado para incluir un índice de dolor generalizado y una escala de gravedad de síntomas (fatiga, sueño no reparador, problemas cognitivos), la presencia de dolor difuso y sensibilidad a la palpación sigue siendo la piedra angular del diagnóstico clínico.

PREGUNTA 87 **Respuesta: D**

Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS

1.09.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La alternativa correcta es Trastorno por somatización porque el paciente presenta múltiples síntomas físicos (molestias faríngeas fluctuantes, globus, cefalea tensional, fibromialgia) sin una causa orgánica demostrable, y además tiene antecedentes de síndrome de intestino irritable, lo cual es común en pacientes con trastornos somatomorfos. El globus faríngeo, la sensación de "pelota en la garganta", es un síntoma típico de somatización, especialmente cuando no hay hallazgos al examen físico. La guía GES sobre depresión, aunque menciona síntomas somáticos en la depresión, no los prioriza en el diagnóstico diferencial del globus. En Chile, estos trastornos son frecuentemente subdiagnosticados, lo que resalta la importancia de considerarlos en el EUNACOM. Los criterios diagnósticos del trastorno por somatización (DSM-5) incluyen la presencia de síntomas somáticos persistentes que causan malestar significativo o alteración en el funcionamiento, así como pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con estos síntomas.

PREGUNTA 88 **Respuesta: B**

Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS

1.11.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El cuadro clínico es una fibromialgia y los marcadores algo elevados no tienen mayor relevancia (recordar que son una trampa).

PREGUNTA 89 **Respuesta: D**

Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica

1.09.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El diagnóstico de osteoporosis secundaria es el más probable debido a la confluencia de tres datos clave en el caso: la edad de la paciente, el valor del T-score y, fundamentalmente, el valor del Z-score. Primero, la paciente tiene 40 años, una edad en la que se considera premenopáusica. La osteoporosis en mujeres premenopáusicas es infrecuente y siempre debe hacer sospechar una causa subyacente. Segundo, su T-score de -2,6 cumple el criterio densitométrico de la OMS para osteoporosis (T-score ≤ -2,5), confirmando que la paciente tiene una densidad mineral ósea patológicamente baja. El dato más decisivo es el Z-score de -2,0. El Z-score compara la densidad mineral ósea de la paciente con la de otras personas de su misma edad, sexo y etnia. Un Z-score de -2,0 o inferior se considera "baja masa ósea para la edad" y es un fuerte indicador de que existe un factor secundario que está causando la pérdida ósea acelerada. A diferencia del T-score, que compara con el pico de masa ósea de un adulto joven sano (30 años), el Z-score es la herramienta fundamental para evaluar la salud ósea en niños, adolescentes y adultos jóvenes premenopáusicos. En resumen, una mujer de 40 años con osteoporosis densitométrica (T-score ≤ -2,5) y un Z-score significativamente bajo (≤ -2,0) tiene, por definición, una alta probabilidad de padecer osteoporosis secundaria. El siguiente paso en su manejo clínico sería iniciar un estudio etiológico exhaustivo para identificar la causa, que podría incluir patologías endocrinas (hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, Cushing), uso de fármacos (corticoides), enfermedades de malabsorción (celiaquía), enfermedades reumatológicas inflamatorias crónicas, entre otras.

PREGUNTA 90 **Respuesta: D**

Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica 1.11.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene una osteoporosis (T score menor o igual a -2,5), por lo que se debe iniciar bifosfonatos. Sin embargo también tiene que recibir vitamina D y calcio. No debería ha- ber distractores correctos.